AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 20 · GO · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

GINECOLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

51	15	3
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 3 · Materno - Infantil · complemento visual del Tomo 20

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 20 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 30

Índice por tipo de imagen 33

Soluciones de la autoevaluación 35

Signos con nombre propio 32

Autoevaluación 34

01 Endocrinología Ginecológica, Ciclo Menstrual & SUA

20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

01 Ciclo menstrual de 28 días 4
02 Síndrome de Turner 4
03 Macroprolactinoma en la RM 5

20.2 Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

04 Acantosis nigricans 5
05 Ovario poliquístico 6
06 Escala de Ferriman-Gallwey 6

20.3 Sangrado Uterino Anormal (SUA)

07 Clasificación PALM-COEIN 7
08 Pólipos endometriales 7
09 Cáncer cervicouterino 8

20.4 Patología Benigna Uterina

10 Clasificación FIGO de los miomas 8
11 Mioma intramural en laparoscopía 9
12 Mioma que comprime el recto 9
13 Mioma en la ecografía transvaginal 10

02 Endometriosis, Piso Pélvico, Infertilidad & Anticoncepción

20.5 Endometriosis y Adenomiosis

14 Endometrioma 10
15 Endometrioma con Doppler 11
16 Implantes de endometriosis en laparoscopía 11
17 Adenomiosis 12

20.6 Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

18 Sistema POP-Q 12
19 Procidencia genital 13

20.7 Infertilidad Conyugal

20 Cavidad uterina en la HSG 13
21 Histerosalpingografía normal 14
22 Hidrosálpinx 14

20.8 Anticoncepción y Planificación Familiar

23 Implante subdérmico 15
24 Retiro del implante 15
25 DIU de cobre y de levonorgestrel 16

03 Infecciones Ginecológicas, Patología Vulvar & Climaterio

20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior

26 Vaginosis bacteriana 16
27 Células clave 17
28 Leucorrea candidiásica 17

20.10 Patología Vulvar y Glándula de Bartolino

29 Quiste de Bartolino 18
30 Absceso de Bartolino 18
31 Liquen escleroso 19

20.11 Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP)

32 Absceso tuboovárico 19
33 Absceso tuboovárico: visión quirúrgica 20
34 Absceso tuboovárico en el Douglas 20
35 Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis 21

04 Oncología Ginecológica & Patología Mamaria

Índice por tema · continuación

20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

36 Lesión de bajo grado en la colposcopía 21
37 Lesión de alto grado 22
38 Toma de Papanicolau 22
39 Citología: lesión de alto grado 23

20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

40 Masa espiculada 23
41 Microcalcificaciones agrupadas 24
42 Piel de naranja 24
43 Quiste simple de mama 25

20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario

44 Endometrio engrosado 25
45 Cáncer de endometrio en la histeroscopía 26
46 Cáncer de ovario avanzado 26

20.16 Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas

47 Ovario aumentado en la torsión 27
48 Signo del remolino 27
49 Doppler en la torsión 28
50 Quiste hemorrágico del cuerpo lúteo 28
51 Quiste hemorrágico de 5 cm 29

01 TEMA 20.1 · FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL, EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-OVARIO Y ESTUDIO DE LA AMENORREA

ESQUEMA

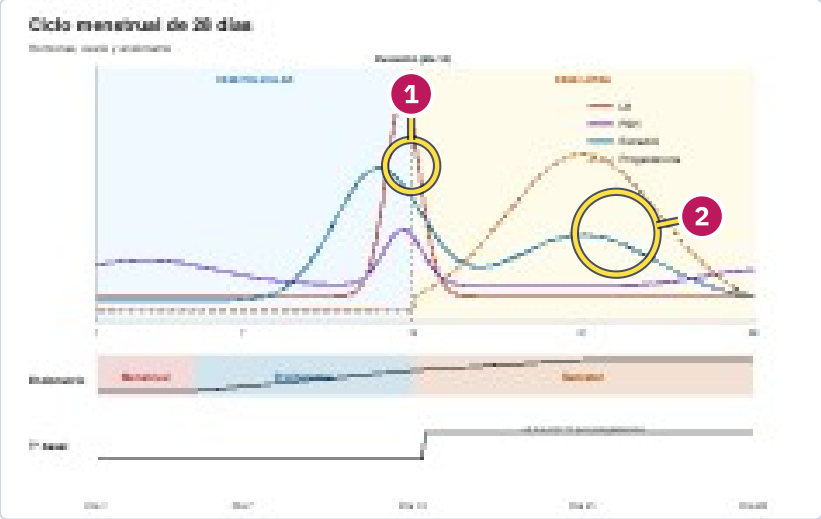


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1. Peak de LH
2. Progesterona

DIAGNÓSTICO

Ciclo menstrual de 28 días

Peak de LH en el día 14 y progesterona en la fase lútea.

CONDUCTA INICIAL

Amenorrea: primero descartar embarazo.

3.01.1.012	Amenorrea	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.03.1.010	Amenorrea	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ciclo anovulatorio: sin alza de progesterona.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P19 «Una paciente de 22 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de...» → **Amenorrea hipotalámica**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 6
Tema 20.1

Clase 20.1 en video

02 TEMA 20.1 · FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL, EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-OVARIO Y ESTUDIO DE LA AMENORREA

FOTO CLÍNICA

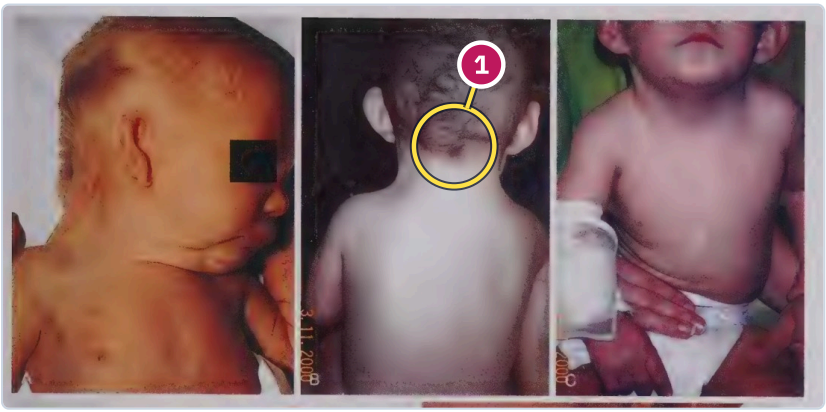


Imagen: Zitelli & Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, p. 37

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cuello alado

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Turner

Cuello alado y linfedema.

CONDUCTA INICIAL

Amenorrea primaria con FSH alta: cariograma.

3.01.1.012	Amenorrea	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Noonan: cariotipo normal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 6
Tema 20.1

Clase 20.1 en video

03 TEMA 20.1 · FISIOLOGÍA DEL CICLO MENSTRUAL, EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-OVARIO Y ESTUDIO DE LA AMENORREA

IMAGEN RADIOLÓGICA

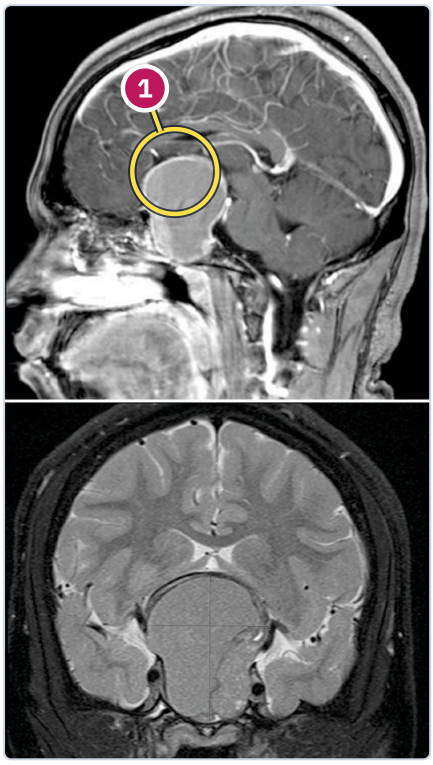


Imagen: Manual AMIR Endocrinología, p. 24

QUÉ TIENES QUE VER

1 Macroadenoma

DIAGNÓSTICO

Macroprolactinoma en la RM

Masa selar.

CONDUCTA INICIAL

Prolactina muy alta: cabergolina.

1.03.1.016 Hiperprolactinemia

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pseudoprolactinoma: prolactina moderada.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P111 «Una paciente de 38 años, usuaria de anticonceptivos combinados orales, desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de…» → **Solicitar niveles de prolactina**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA p. 6 Tema 20.1

Clase 20.1 en video

04 TEMA 20.2 · SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP)

FOTO CLÍNICA

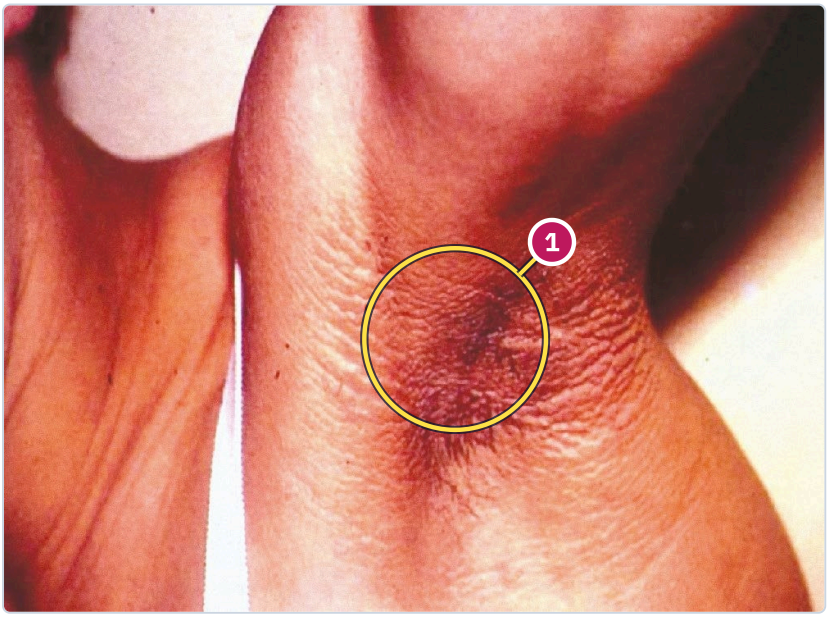


Imagen: Manual AMIR Dermatología, p. 30

QUÉ TIENES QUE VER

1 Acantosis

DIAGNÓSTICO

Acantosis nigricans

Hiperpigmentación aterciopelada en el pliegue.

CONDUCTA INICIAL

SOP con resistencia a la insulina: metformina y estilo de vida.

3.01.3.015 Síndrome de ovario poliquístico

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Suciedad.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA p. 11 Tema 20.2

Clase 20.2 en video

05 TEMA 20.2 · SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP)

ECOGRAFÍA

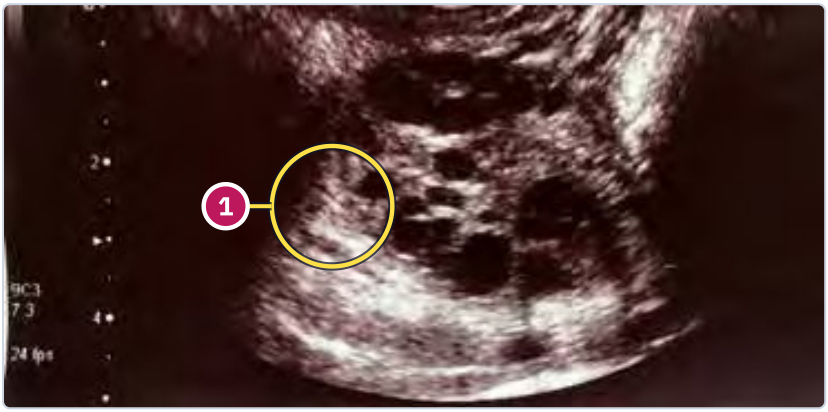


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 35

QUÉ TIENES QUE VER

1 Folículos periféricos

DIAGNÓSTICO

Ovario poliquístico

Muchos folículos periféricos en collar.

CONDUCTA INICIAL

Rotterdam: 2 de 3 criterios.

3.01.3.015 **Síndrome de ovario poliquístico**
examen/procedimiento

3.01.1.022 **Oligoanovulación crónica**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ovario multifolicular normal.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P157 «Mujer de 28 años con amenorrea de 4 meses, hirsutismo, acné y obesidad central. Ecografía: ovarios con múltiples folículos periféricos….» → **Síndrome de ovario poliquístico (SOP)**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 11
Tema 20.2

Clase 20.2 en video

06 TEMA 20.2 · SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP)

ESQUEMA

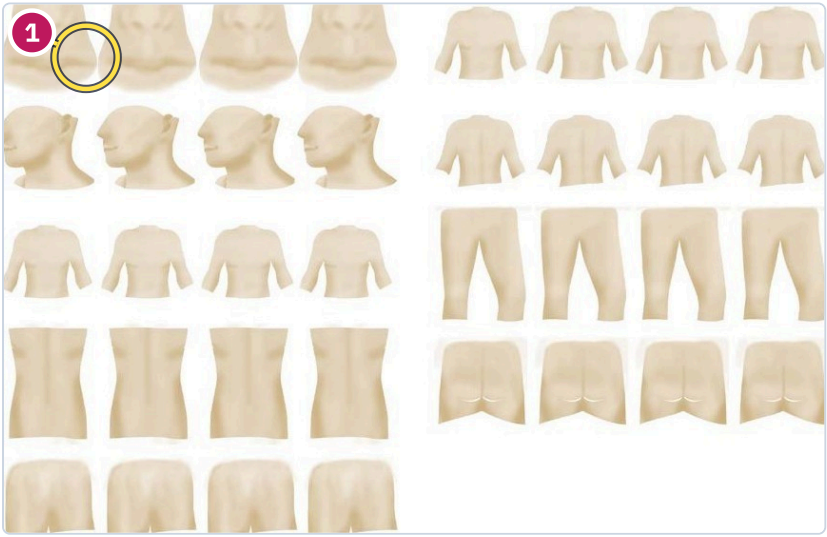


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics 22.ª ed., p. 4295

QUÉ TIENES QUE VER

1 Labio superior

DIAGNÓSTICO

Escala de Ferriman-Gallwey

Vello en 9 zonas, de 0 a 4.

CONDUCTA INICIAL

≥ 8: hirsutismo; estudiar andrógenos.

1.03.1.008 **Hirsutismo**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hipertricosis: vello no androgénico.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P110 «Una paciente de 17 años, con antecedente se haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene hirsutismo en…» → **17-hidroxi-progesterona**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 11
Tema 20.2

Clase 20.2 en video

07 TEMA 20.3 · SANGRADO UTERINO ANORMAL (SUA)

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1. PALM
2. COEIN

DIAGNÓSTICO

Clasificación PALM-COEIN

Causas estructurales y no estructurales del SUA.

CONDUCTA INICIAL

Sobre 40 años o con factores de riesgo: biopsia endometrial.

`3.01.1.018` **Hemorragia genital anormal**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Sangrado del embarazo.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P5** «Una paciente de 48 años consulta por sangrado uterino, que no ha cesado desde su última menstruación, que inició hace dos semanas. Se solicita…» → **Biopsia de endometrio**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 15** Tema 20.3

Clase 20.3 en video

08 TEMA 20.3 · SANGRADO UTERINO ANORMAL (SUA)

ECOGRAFÍA

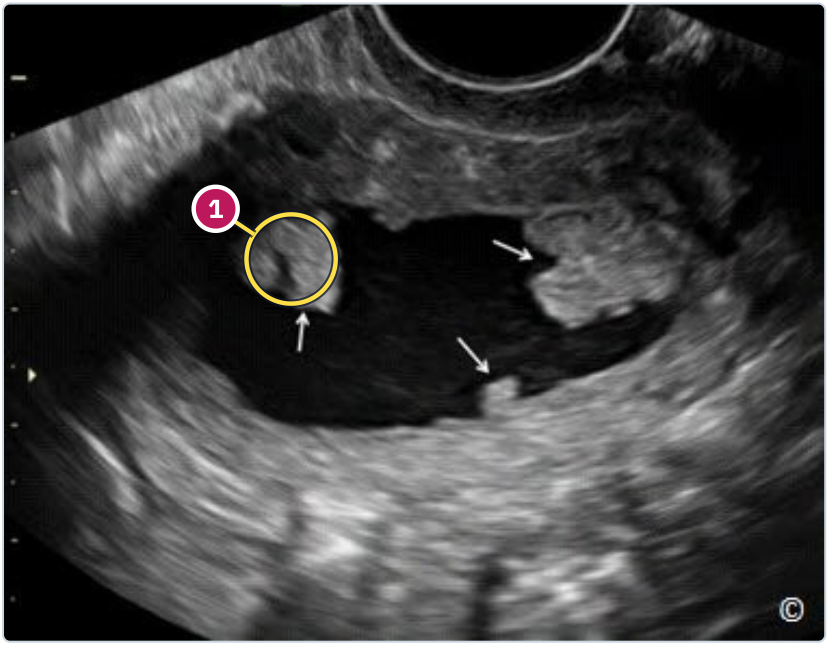


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 245

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pólipo

DIAGNÓSTICO

Pólipos endometriales

Imágenes ecogénicas en la cavidad (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Histeroscopía y resección.

`3.01.1.023` **Patología benigna del endometrio (hiperplasia, pólipos…)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mioma submucoso.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P120** «Una paciente de 68 años, nulípara, con antecedente de menopausia a los 50 años, consulta debido a sangrado genital intermitente de 2 meses de…» → **Hiperplasia endometrial**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 15** Tema 20.3

Clase 20.3 en video

09 TEMA 20.3 · SANGRADO UTERINO ANORMAL (SUA)

FOTO CLÍNICA

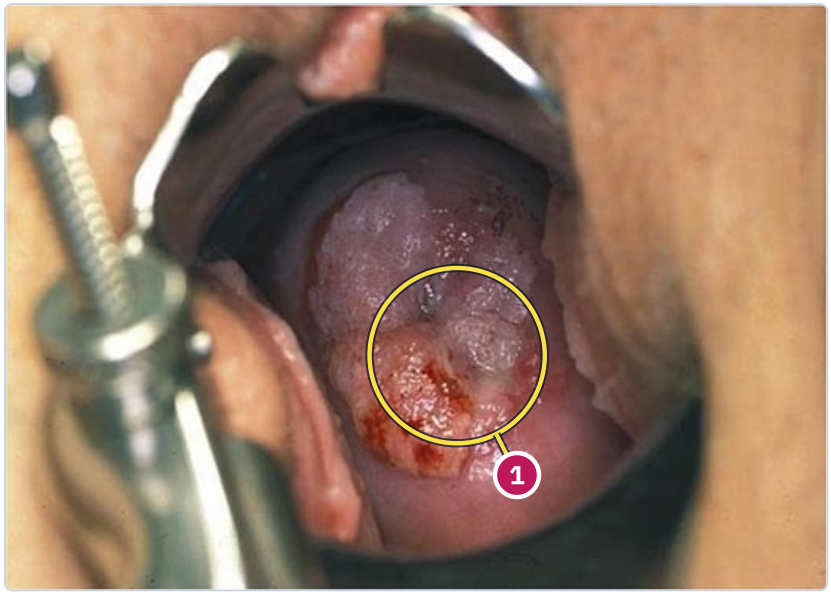


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 276

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tumor

DIAGNÓSTICO

Cáncer cervicouterino

Lesión exofítica sangrante del cuello.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia; etapificar.

3.01.1.013 Cáncer cervicouterino

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Ectropión.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P177 «Una paciente de 34 años consulta por genitorragia y sinusorragia, por lo que se realiza una especuloscopía, que muestra una lesión cervical…» → **Colposcopía y biopsia**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 15
Tema 20.3

Clase 20.3 en video

10 TEMA 20.4 · PATOLOGÍA BENIGNA UTERINA

ESQUEMA

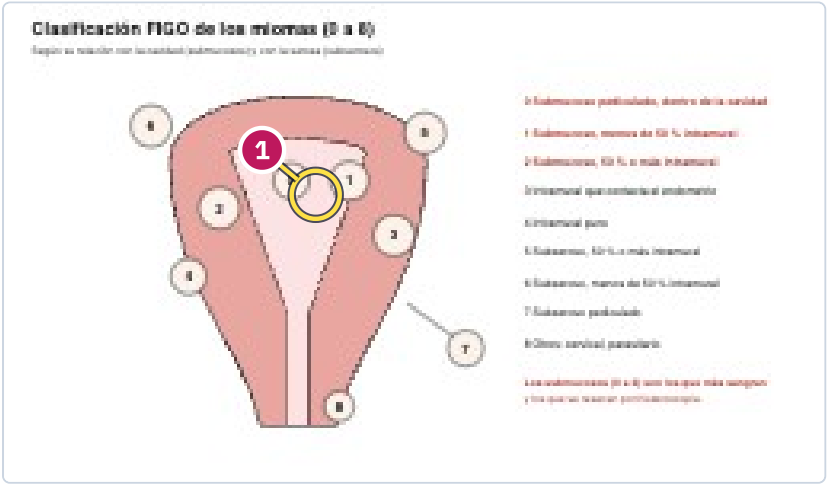


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Submucoso

DIAGNÓSTICO

Clasificación FIGO de los miomas

0 a 8 según la relación con la cavidad y la serosa.

CONDUCTA INICIAL

Submucosos sangran más: histeroscopía.

3.01.1.021 Mioma uterino

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Pólipo.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 20
Tema 20.4

Clase 20.4 en video

11 TEMA 20.4 · PATOLOGÍA BENIGNA UTERINA

FOTO CLÍNICA

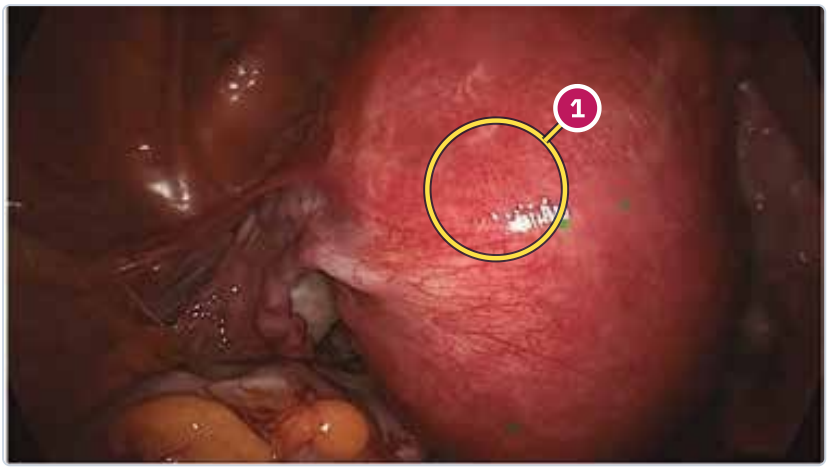


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 63

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mioma

DIAGNÓSTICO

Mioma intramural en laparoscopía

Nódulo que deforma el útero.

CONDUCTA INICIAL

Sintomático: miomectomía o histerectomía.

3.01.1.021 Mioma uterino

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Adenomiosis.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P63 «Una paciente de 30 años, nulípara, consulta por presentar reglas abundantes, asociado a astenia e hipersomnia. Al examen físico destacan mucosas…» → **Miomectomía**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 20
Tema 20.4

Clase 20.4 en video

12 TEMA 20.4 · PATOLOGÍA BENIGNA UTERINA

IMAGEN RADIOLÓGICA

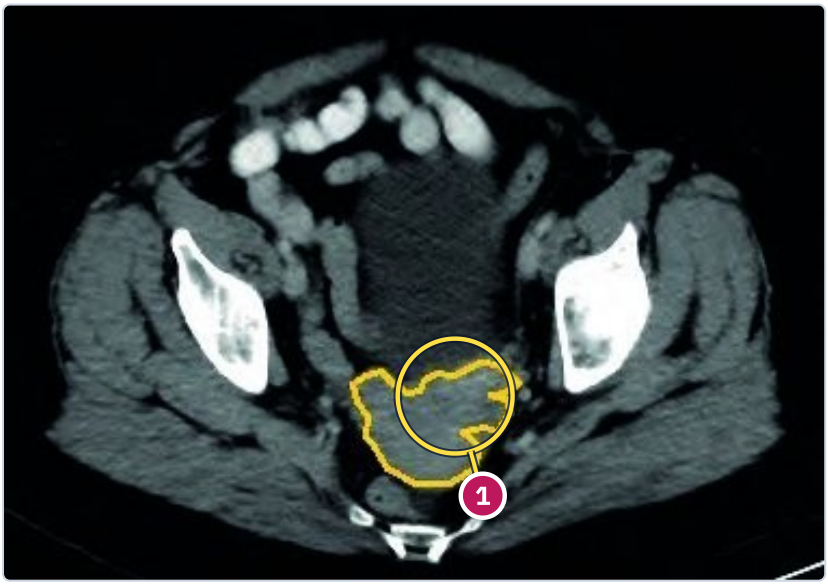


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 138

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mioma

DIAGNÓSTICO

Mioma que comprime el recto

Masa uterina delineada en la TC.

CONDUCTA INICIAL

Síntomas compresivos: cirugía.

3.01.1.021 Mioma uterino

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Tumor ovárico.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 20
Tema 20.4

Clase 20.4 en video

13 TEMA 20.4 · PATOLOGÍA BENIGNA UTERINA

ECOGRAFÍA

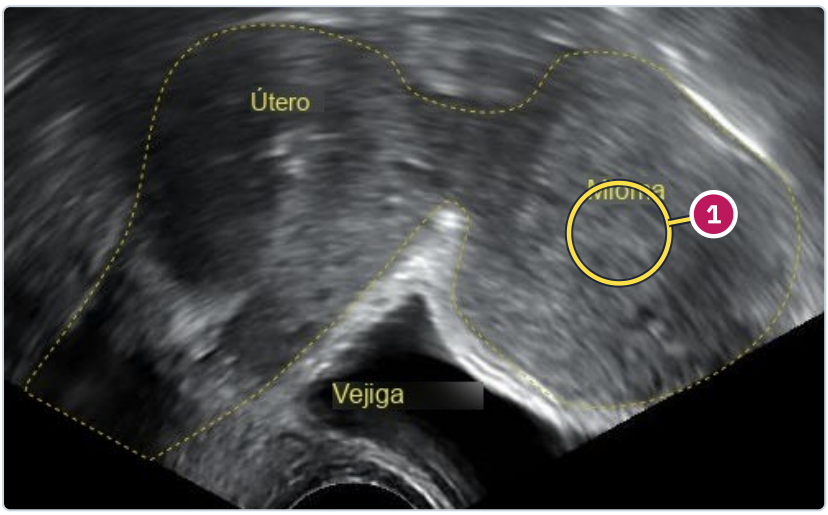


Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mioma

DIAGNÓSTICO

Mioma en la ecografía transvaginal

Nódulo hipoecogénico en el útero.

CONDUCTA INICIAL

Seguimiento si es asintomático.

3.01.1.021 Mioma uterino

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Adenomiosis: sin bordes netos.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA p. 20 Tema 20.4

Clase 20.4 en video

14 TEMA 20.5 · ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS

ECOGRAFÍA

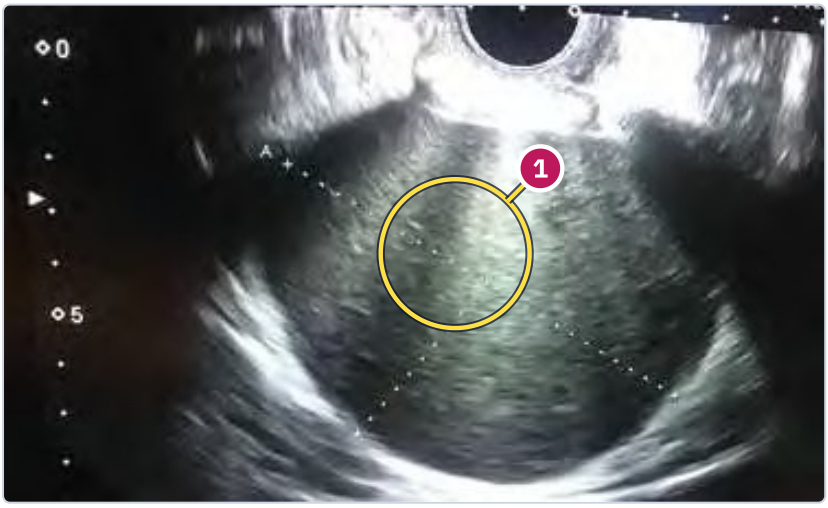


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 74

QUÉ TIENES QUE VER

1 Endometrioma

DIAGNÓSTICO

Endometrioma

Quiste con ecos finos en vidrio esmerilado.

CONDUCTA INICIAL

Mayor de 4 cm o sintomático: cirugía.

3.01.1.015 Endometriosis

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Quiste hemorrágico: patrón en red.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P54 «Mujer de 38 años con dismenorrea severa, dispareunia profunda y menometrorragia. Ecografía transvaginal: útero aumentado de tamaño con ecotextura…» → **Adenomiosis**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA p. 26 Tema 20.5

Clase 20.5 en video

15 TEMA 20.5 · ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS

ECOGRAFÍA

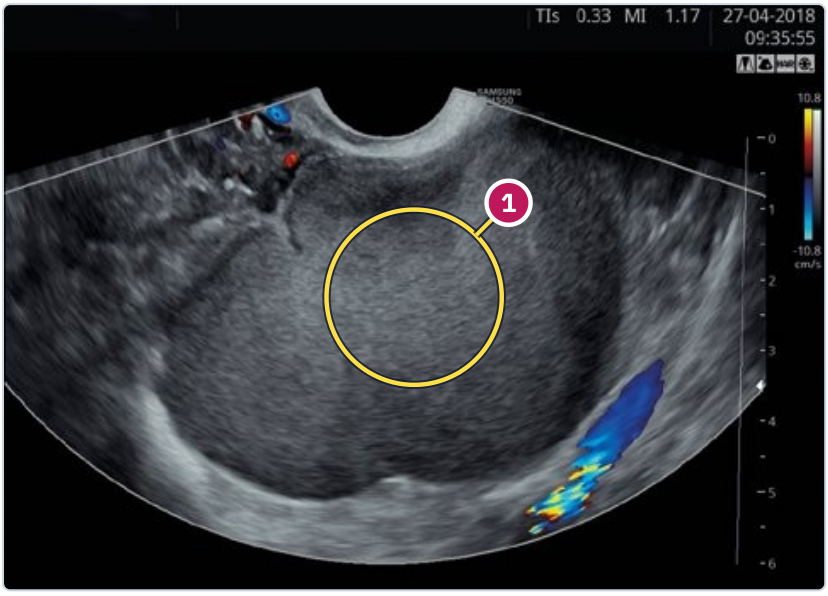


Imagen: Manual AMIR Ginecología y Obstetricia, p. 101

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quiste avascular

DIAGNÓSTICO

Endometrioma con Doppler

Sin flujo interno.

CONDUCTA INICIAL

Dismenorrea, dispareunia, infertilidad.

3.01.1.015 **Endometriosis**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tumor sólido: flujo interno.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 27** Tema 20.5

Clase 20.5 en video

16 TEMA 20.5 · ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS

FOTO CLÍNICA

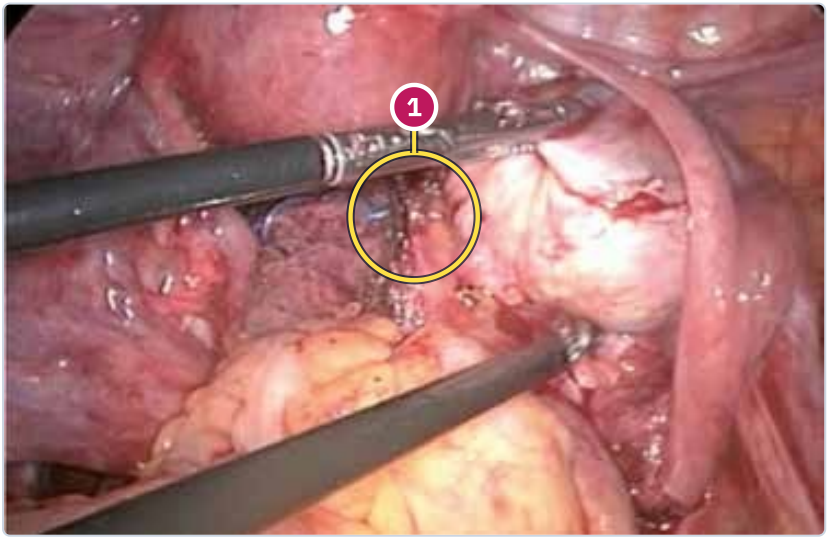


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 75

QUÉ TIENES QUE VER

1 Implantes

DIAGNÓSTICO

Implantes de endometriosis en laparoscopía

Lesiones peritoneales.

CONDUCTA INICIAL

Diagnóstico de certeza: laparoscopía.

3.01.1.015 **Endometriosis**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

3.01.1.014 **Dolor pelviano y dismenorrea**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Adherencias por EIP.

PREGUNTA REAL **Julio 2018 · P1** «Una paciente de 15 años, sin antecedentes de importancia, presenta dolor pélvico muy intenso, en relación a la menstruación, que la hace faltar…» → **Ácido mefenámico**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 27** Tema 20.5

Clase 20.5 en video

17 TEMA 20.5 · ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS

ECOGRAFÍA

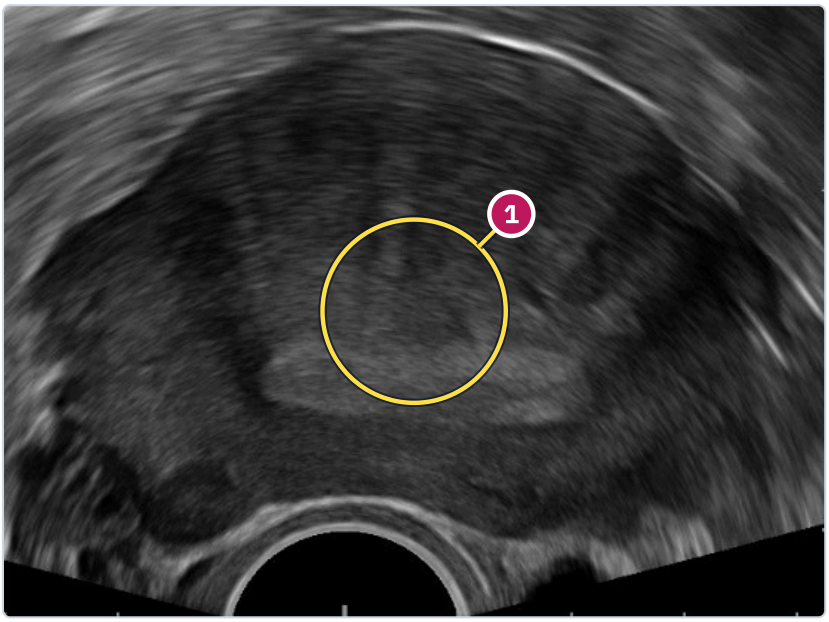


Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Miometrio heterogéneo

DIAGNÓSTICO

Adenomiosis

Útero globoso con miometrio heterogéneo.

CONDUCTA INICIAL

Hormonal o histerectomía.

3.01.1.015 Endometriosis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mioma: bordes netos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 29** Tema 20.5

Clase 20.5 en video

18 TEMA 20.6 · PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS (POP-Q) E INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO VS URGENCIA

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estadios

DIAGNÓSTICO

Sistema POP-Q

Puntos medidos respecto al himen.

CONDUCTA INICIAL

Estadio III–IV sintomático: cirugía o pesario.

3.01.1.026 Prolapso genital — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Incontinencia aislada.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 32** Tema 20.6

Clase 20.6 en video

19 TEMA 20.6 · PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS (POP-Q) E INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO VS URGENCIA

FOTO CLÍNICA

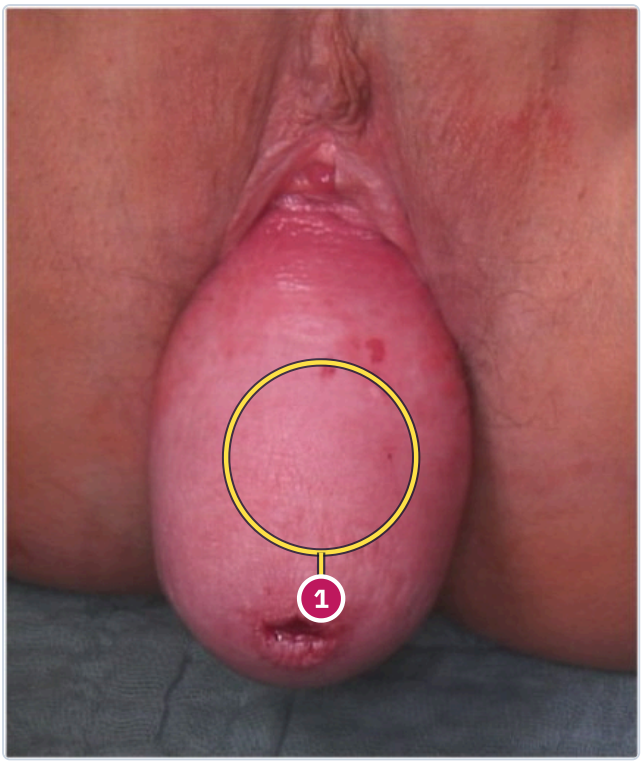


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Prolapso total

DIAGNÓSTICO

Procidencia genital

Útero completamente fuera.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía o pesario.

3.01.1.026 Prolapso genital

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mioma prolapsado.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P45 «Una paciente de 58 años, multípara de cuatro, presenta sensación de peso vaginal, asociada a escapes de orina, al inicio del deseo miccional. Al...» → **Realizar pelvic organ prolapse quantification (POP-Q)**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 32
Tema 20.6

Clase 20.6 en video

20 TEMA 20.7 · INFERTILIDAD CONYUGAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

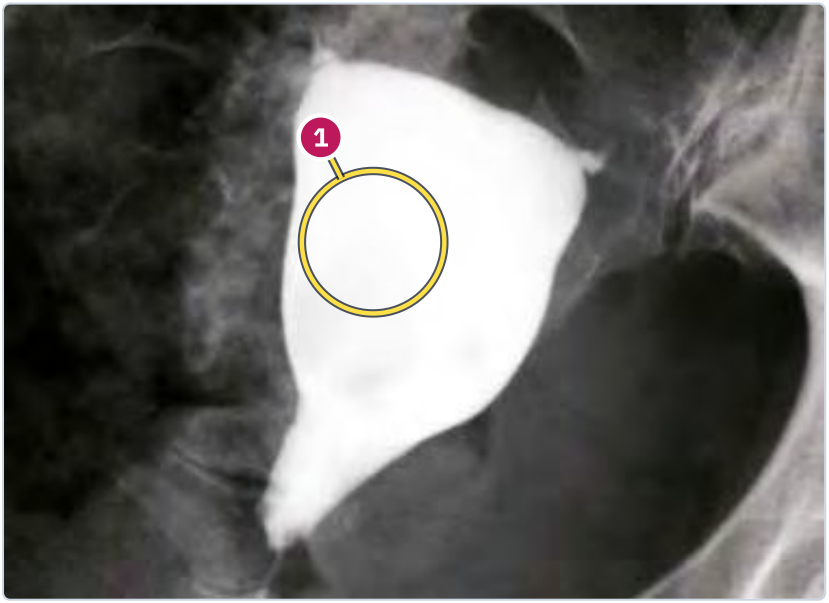


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 50

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cavidad uterina

DIAGNÓSTICO

Cavidad uterina en la HSG

Cavidad rellena de contraste.

CONDUCTA INICIAL

Estudio de infertilidad.

3.01.4.001 Histerosalpingografía

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Útero malformado.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 35
Tema 20.7

Clase 20.7 en video

21 TEMA 20.7 · INFERTILIDAD CONYUGAL

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 50

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trompa permeable

DIAGNÓSTICO

Histerosalpingografía normal

Paso de contraste por ambas trompas.

CONDUCTA INICIAL

Trompas permeables.

3.01.4.001 Histerosalpingografía — examen/procedimiento

3.01.1.020 Infertilidad conyugal — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hidrosálpinx.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P146** «Una paciente de 38 años consulta porque lleva dos años intentando embarazarse, junto a su pareja. Sus reglas son regulares, su examen físico es…» → **Histerosalpingografía**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 36** Tema 20.7

Clase 20.7 en video

22 TEMA 20.7 · INFERTILIDAD CONYUGAL

ECOGRAFÍA

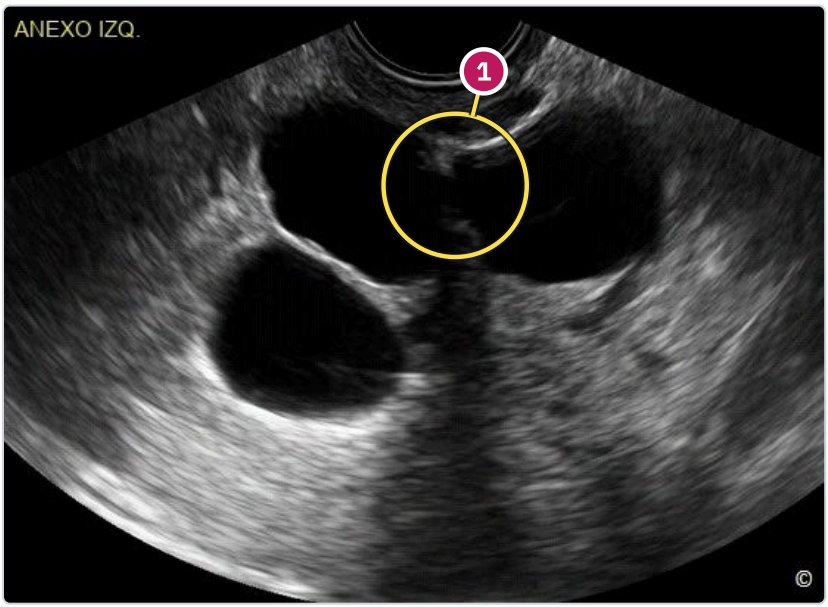


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 272

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trompa dilatada

DIAGNÓSTICO

Hidrosálpinx

Trompa dilatada con líquido.

CONDUCTA INICIAL

Salpingectomía antes de FIV.

3.01.1.020 Infertilidad conyugal — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Quiste ovárico.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P149** «Una pareja joven consulta por infertilidad, refieren que llevan 15 meses intentando tener hijos pero no han tenido resultado, ambos no tienen…» → **Test post coital**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 36** Tema 20.7

Clase 20.7 en video

23 TEMA 20.8 · ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

FOTO CLÍNICA

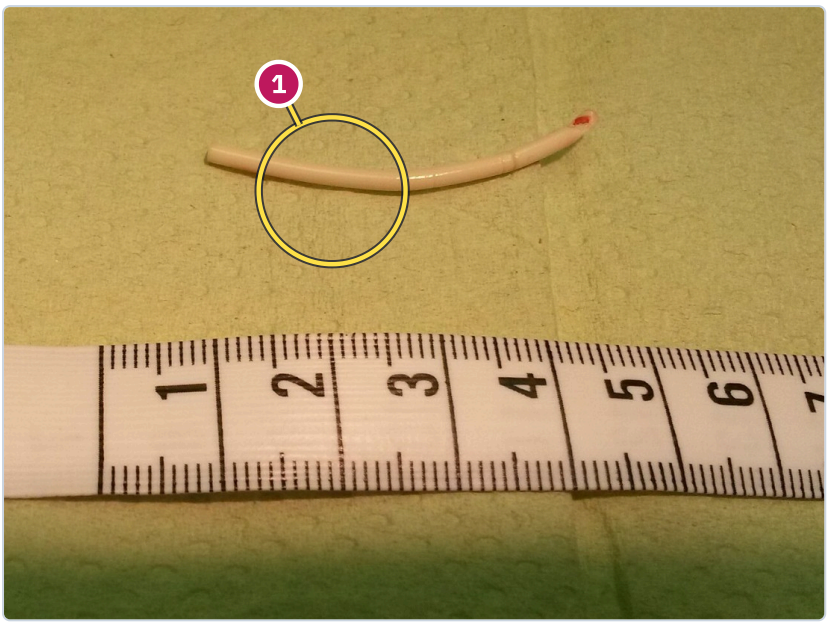


Imagen: Wikimedia Commons «Implanon 04.jpg», CC BY-SA 4.0, Vera de Kok

QUÉ TIENES QUE VER

1 Implante

DIAGNÓSTICO

Implante subdérmico

Varilla de etonogestrel.

CONDUCTA INICIAL

Dura 3 años.

3.01.3.008 Anticoncepción

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

DIU.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 40** Tema 20.8

Clase 20.8 en video

24 TEMA 20.8 · ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

FOTO CLÍNICA

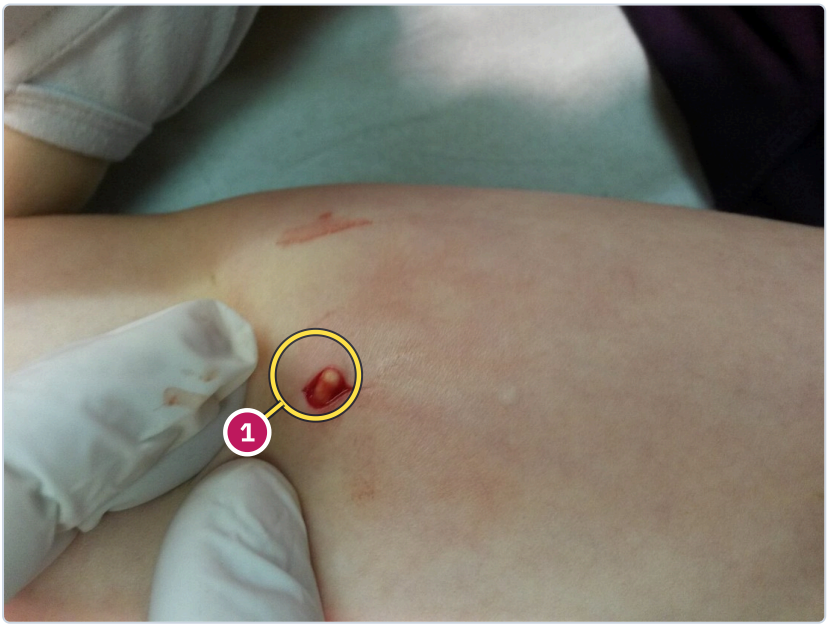


Imagen: Wikimedia Commons «Implanon 02.jpg», CC BY-SA 4.0, Vera de Kok

QUÉ TIENES QUE VER

1 Incisión

DIAGNÓSTICO

Retiro del implante

Incisión pequeña en el brazo.

CONDUCTA INICIAL

Anestesia local.

3.01.3.008 Anticoncepción

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Infección.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 40** Tema 20.8

Clase 20.8 en video

25 TEMA 20.8 · ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

FOTO CLÍNICA



Imagen: Williams Gynecology 4.ª ed., Fig. 5-3

QUÉ TIENES QUE VER

1 DIU de cobre

DIAGNÓSTICO

DIU de cobre y de levonorgestrel

Dispositivos intrauterinos.

CONDUCTA INICIAL

Cobre: también anticoncepción de emergencia hasta 5 días.

3.01.3.008 Anticoncepción

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Implante.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P44 «Paciente que tuvo relaciones sexuales hace 96 horas sin protección, solicita anticoncepción de emergencia. ¿Qué indicar?» → **Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 40
Tema 20.8

Clase 20.8 en video

26 TEMA 20.9 · INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

FOTO CLÍNICA

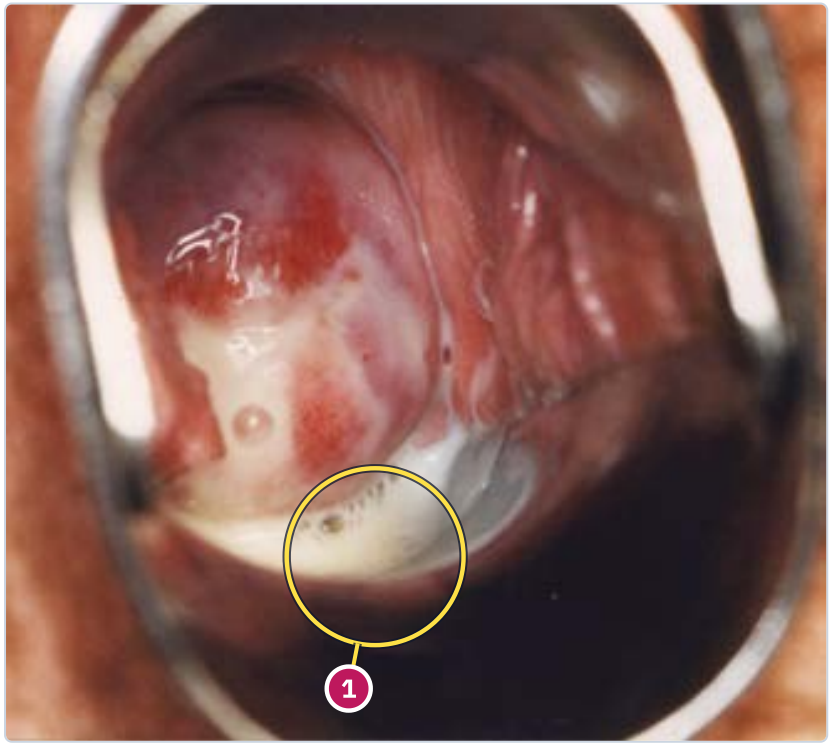


Imagen: Kumar and Clark's Clinical Medicine, p. 1586

QUÉ TIENES QUE VER

1 Flujo

DIAGNÓSTICO

Vaginosis bacteriana

Flujo blanco grisáceo homogéneo.

CONDUCTA INICIAL

Metronidazol.

3.01.1.019 Infecciones genitourinarias

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Candidiasis: flujo grumoso.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P121 «Mujer de 28 años con dispareunia (dolor a la penetración), flujo vaginal gris homogéneo con mal olor (peor post coito) y pH vaginal 5.5. Test de…» → **Vaginosis bacteriana: metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 48
Tema 20.9

Clase 20.9 en video

27 TEMA 20.9 · INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: CDC PHIL 3720 (CDC/M. Rein), dominio público

QUÉ TIENES QUE VER

1 Célula clave

DIAGNÓSTICO

Células clave

Células epiteliales cubiertas de bacterias.

CONDUCTA INICIAL

Criterio de Amsel.

3.01.1.019 Infecciones genitourinarias
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

3.01.5.008 Flujo vaginal (pH)
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Célula normal: borde neto.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 48** Tema 20.9

Clase 20.9 en video

28 TEMA 20.9 · INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

FOTO CLÍNICA

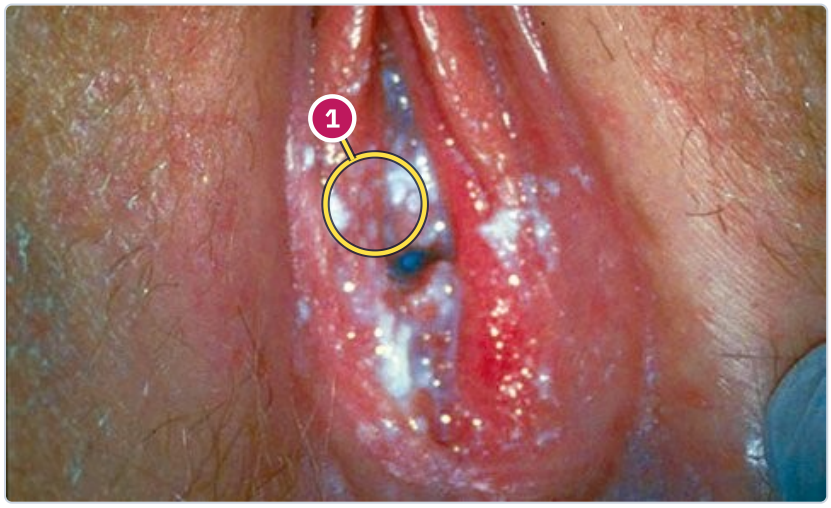


Imagen: Manual AMIR Ginecología y Obstetricia, p. 106

QUÉ TIENES QUE VER

1 Flujo grumoso

DIAGNÓSTICO

Leucorrea candidiásica

Flujo blanco grumoso.

CONDUCTA INICIAL

Clotrimazol o fluconazol.

2.01.1.106 Candidiasis urogenital
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

3.01.1.019 Infecciones genitourinarias
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Vaginosis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 48** Tema 20.9

Clase 20.9 en video

29 TEMA 20.10 · PATOLOGÍA VULVAR Y GLÁNDULA DE BARTOLINO

FOTO CLÍNICA

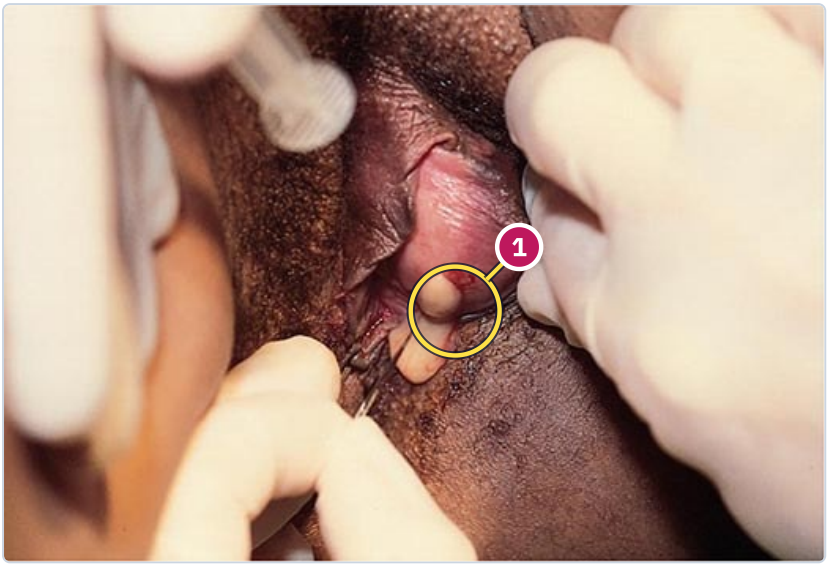


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 269

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quiste

DIAGNÓSTICO

Quiste de Bartolino

Aumento de volumen indoloro del labio.

CONDUCTA INICIAL

Asintomático: observar.

3.01.2.002 Absceso glándula de Bartolino
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Absceso: doloroso.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 53
Tema 20.10

Clase 20.10 en video

30 TEMA 20.10 · PATOLOGÍA VULVAR Y GLÁNDULA DE BARTOLINO

FOTO CLÍNICA

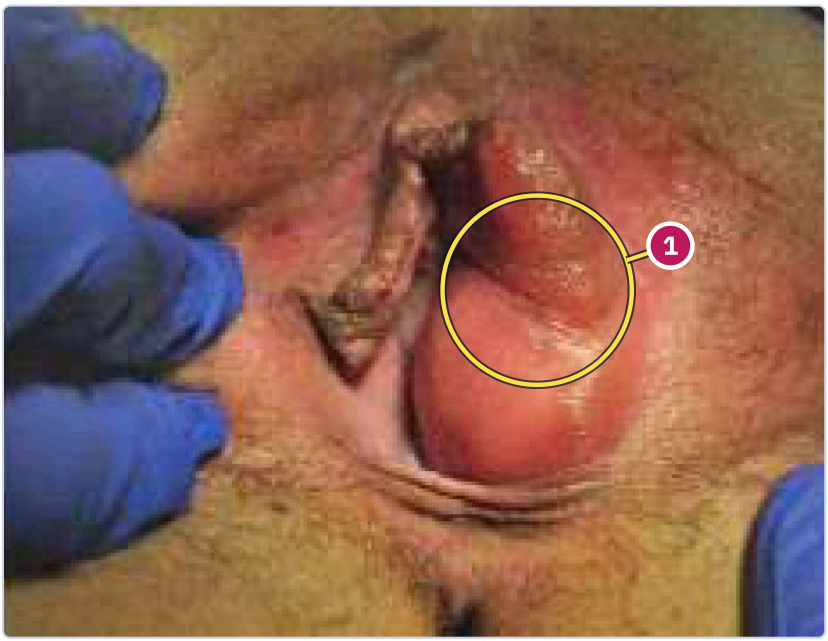


Imagen: Williams Gynecology 4.ª ed., Fig. 3-18

QUÉ TIENES QUE VER

1 Absceso

DIAGNÓSTICO

Absceso de Bartolino

Masa dolorosa y roja.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje y marsupialización.

3.01.2.002 Absceso glándula de Bartolino
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

3.01.5.004 Drenaje abceso glándula Bartolino
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Quiste.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P148** «Mujer de 20 años tras parto vaginal con episiotomía presenta aumento de volumen doloroso, azulado y fluctuante en el labio mayor derecho de 48…» → **Absceso vulvar: drenaje + antibióticos**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 53
Tema 20.10

Clase 20.10 en video

31 TEMA 20.10 · PATOLOGÍA VULVAR Y GLÁNDULA DE BARTOLINO

FOTO CLÍNICA

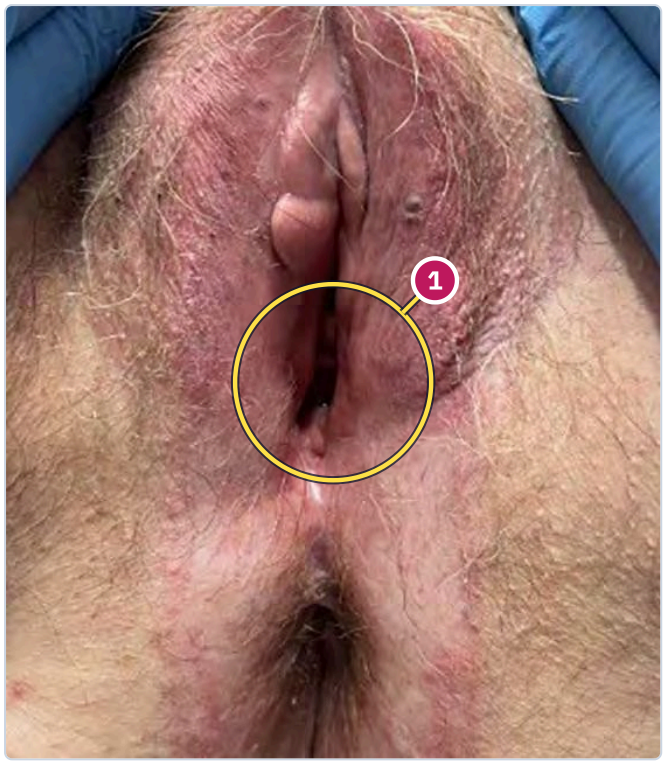


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 106

QUÉ TIENES QUE VER

1 Piel blanca

DIAGNÓSTICO

Liquen escleroso

Piel vulvar blanca y atrófica.

CONDUCTA INICIAL

Corticoide potente; biopsia si hay úlcera.

3.01.1.019 Infecciones genitourinarias

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Vitíligo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 53** Tema 20.10

Clase 20.10 en video

32 TEMA 20.11 · ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (EIP / PIP)

ECOGRAFÍA

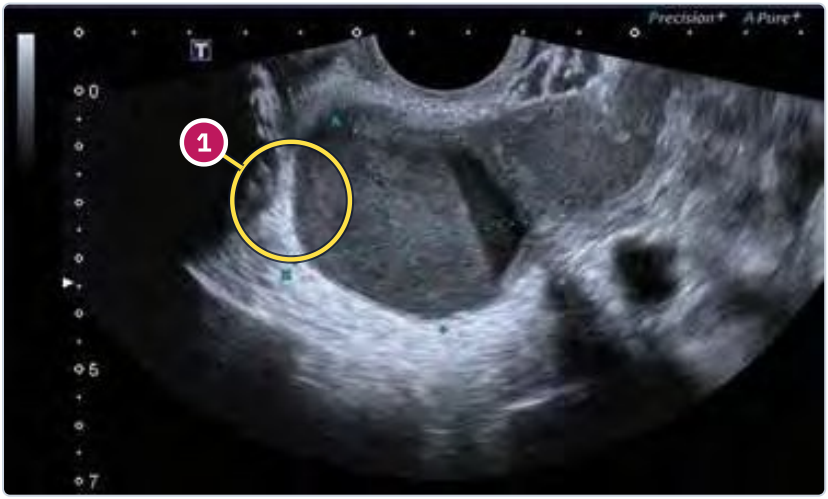


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 102

QUÉ TIENES QUE VER

1 Absceso

DIAGNÓSTICO

Absceso tuboovárico

Masa anexial compleja.

CONDUCTA INICIAL

Hospitalizar: antibióticos EV.

3.01.1.025 Proceso inflamatorio pelviano

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Endometrioma.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P80** «Una paciente de mantiene actividad sexual, sin método anticonceptivo, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal de 3 días de evolución. Al…» → **Iniciar tratamiento antibiótico**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 58** Tema 20.11

Clase 20.11 en video

33 TEMA 20.11 · ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (EIP / PIP)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 102

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pus

DIAGNÓSTICO

Absceso tuboovárico: visión quirúrgica

Pus en la pelvis.

CONDUCTA INICIAL

Sin respuesta en 48–72 h: drenaje.

3.01.2.018 Pelviperitonitis

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Apendicitis.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P95 «Una paciente de 25 años consulta en el servicio de urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución, que ha aumentado de intensidad. Es...» → **Pelviperitonitis**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 58
Tema 20.11

Clase 20.11 en video

34 TEMA 20.11 · ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (EIP / PIP)

ECOGRAFÍA

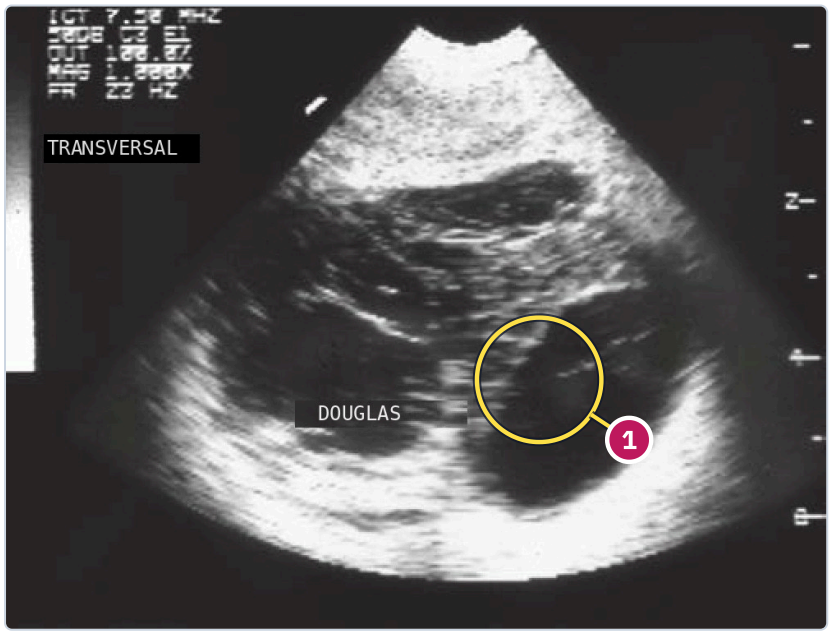


Imagen: Reardon, Pocket Atlas of Emergency Ultrasound, p. 281

QUÉ TIENES QUE VER

1 Colección

DIAGNÓSTICO

Absceso tuboovárico en el Douglas

Colección en el fondo de saco.

CONDUCTA INICIAL

Pelviperitonitis: drenaje.

3.01.2.018 Pelviperitonitis

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hemoperitoneo.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 58
Tema 20.11

Clase 20.11 en video

35 TEMA 20.11 · ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (EIP / PIP)

FOTO CLÍNICA

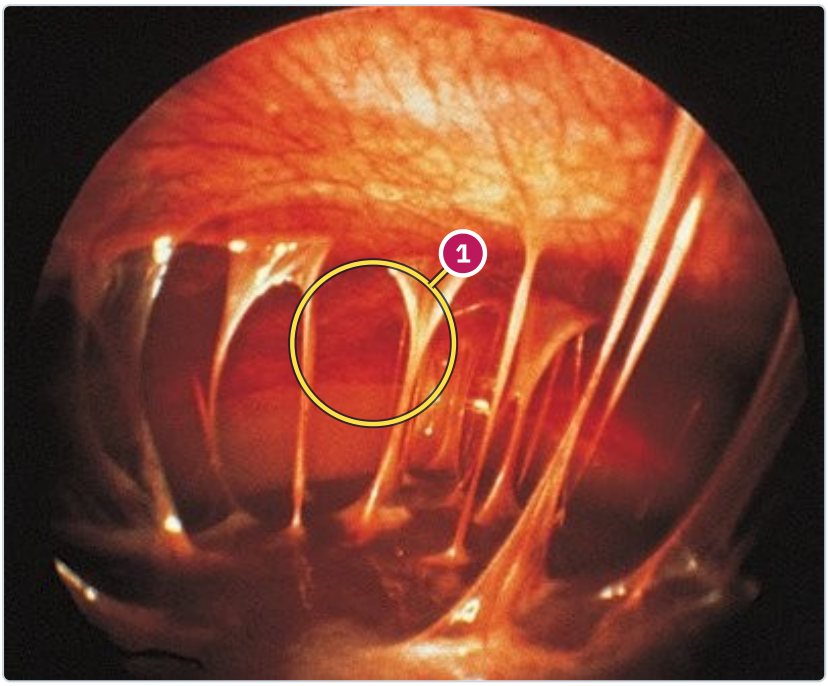


Imagen: Goljan Rapid Review Pathology, Link 22-85

QUÉ TIENES QUE VER

1 Adherencias

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis

Adherencias perihepáticas en cuerdas de violín.

CONDUCTA INICIAL

Antecedente de EIP por Chlamydia.

3.01.1.025 **Proceso inflamatorio pelviano**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Colecistitis.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 57
Tema 20.11

Clase 20.11 en video

36 TEMA 20.13 · CÁNCER CERVICOUTERINO (CCU) GES, LESIONES PREINVASORAS (BETHESDA) Y COLPOSCOPÍA

FOTO CLÍNICA

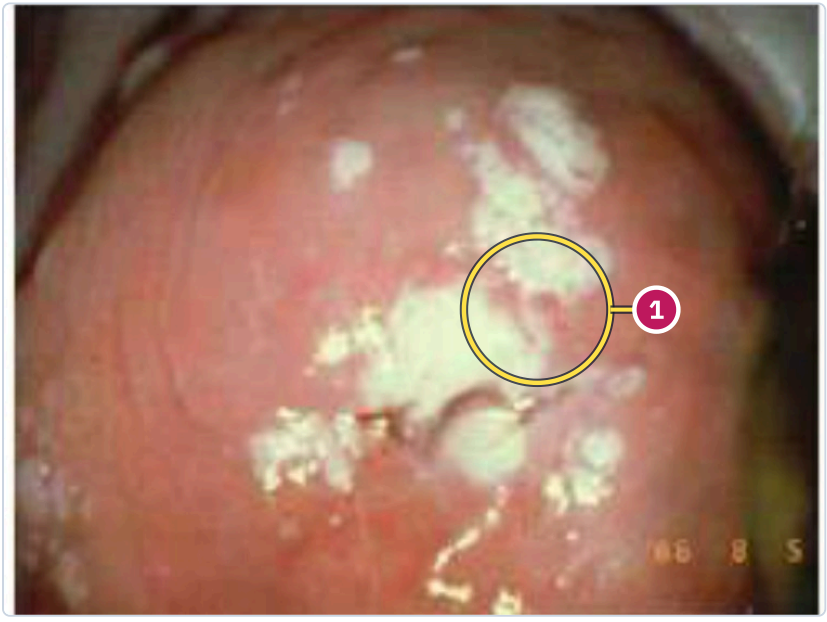


Imagen: Williams Gynecology 4.ª ed., Fig. 29-12

QUÉ TIENES QUE VER

1 Zona acetoblanca

DIAGNÓSTICO

Lesión de bajo grado en la colposcopía

Epitelio acetoblanco fino.

CONDUCTA INICIAL

Seguimiento: la mayoría regresa.

3.01.1.016 **Enfermedad preinvasora del cuello uterino-Lesiones genitales intraepiteliales (NIE-HPV)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Metaplasia.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P91 «Una paciente de 35 años, multípara de 1, se realiza PAP de control, que es informado como presencia de atipias escamosas de significado incierto…» → **Solicitar reacción de cadena de polimerasa para virus…**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 72
Tema 20.13

Clase 20.13 en video

37 TEMA 20.13 · CÁNCER CERVICOUTERINO (CCU) GES, LESIONES PREINVASORAS (BETHESDA) Y COLPOSCOPÍA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Williams Gynecology 4.ª ed., Fig. 29-13

QUÉ TIENES QUE VER

1 Zona densa

DIAGNÓSTICO

Lesión de alto grado

Acetoblanco denso con vasos atípicos.

CONDUCTA INICIAL

Conización (LEEP).

3.01.1.016 **Enfermedad preinvasora del cuello uterino-Lesiones genitales intraepiteliales (NIE-HPV)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Bajo grado.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 69** Tema 20.13

Clase 20.13 en video

38 TEMA 20.13 · CÁNCER CERVICOUTERINO (CCU) GES, LESIONES PREINVASORAS (BETHESDA) Y COLPOSCOPÍA

ESQUEMA

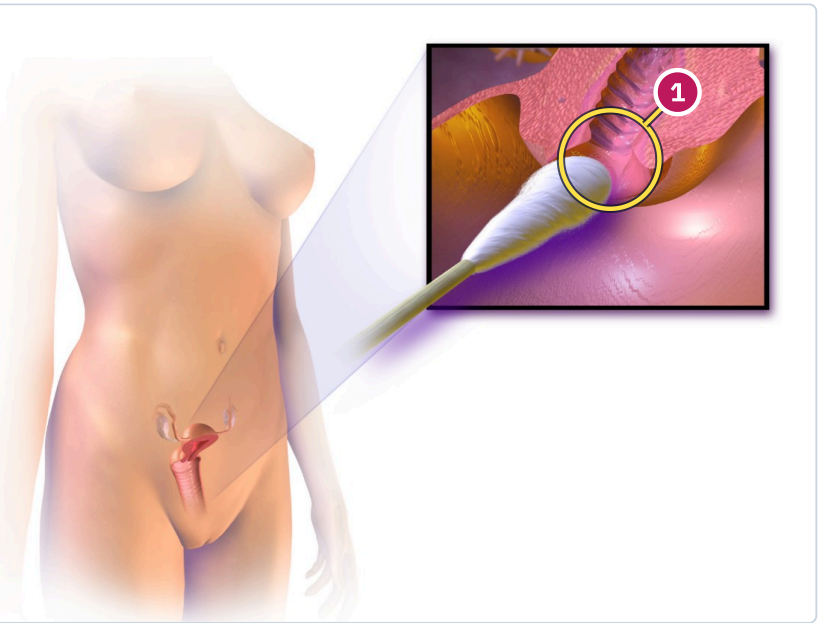


Imagen: Blausen.com staff (2014), CC BY 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cepillado

DIAGNÓSTICO

Toma de Papanicolau

Muestra de la zona de transformación.

CONDUCTA INICIAL

25 a 64 años cada 3 años.

3.01.5.014 **Toma de Papanicolau (incluye hacer el frotis)**

examen/procedimiento

3.01.3.013 **Screening ginecológico: Papanicolau, mamografía**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Toma inadecuada.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2025 · P172** «Una mujer de 34 años, con vacunación completa contra el virus papiloma humano, se realiza un PAP, que es informado como muestra satisfactoria sin…» → **Realizar control de PAP en un año**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 72** Tema 20.13

Clase 20.13 en video

39 TEMA 20.13 · CÁNCER CERVICOUTERINO (CCU) GES, LESIONES PREINVASORAS (BETHESDA) Y COLPOSCOPÍA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

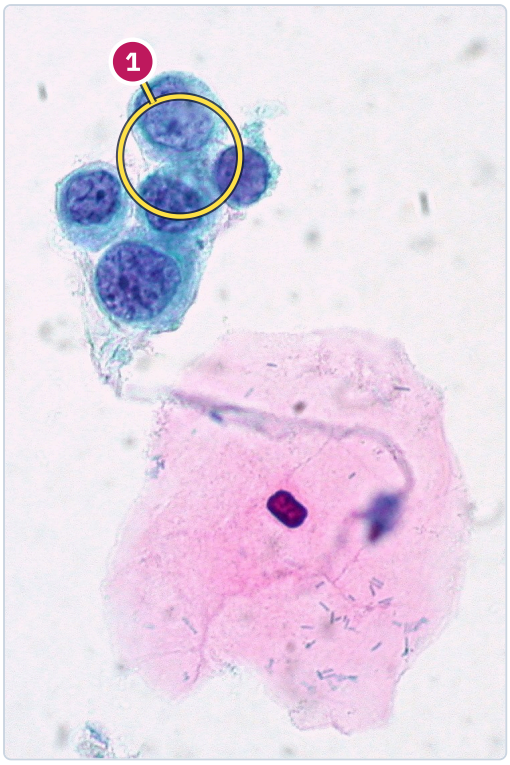


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Células atípicas

DIAGNÓSTICO

Citología: lesión de alto grado

Células con núcleo grande e hipercromático.

CONDUCTA INICIAL

Colposcopía con biopsia.

3.01.4.007 Papanicolau — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Célula normal.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P59 «Mujer de 32 años con PAP que informa "células glandulares atípicas de significado indeterminado" (AGC-NOS). ¿Cuál es la conducta más adecuada?» → **Colposcopía con biopsia y legrado endocervical**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 69** Tema 20.13

Clase 20.13 en video

40 TEMA 20.14 · CÁNCER DE MAMA GES, TAMIZAJE MAMOGRÁFICO (BI-RADS) Y PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA

IMAGEN RADIOLÓGICA

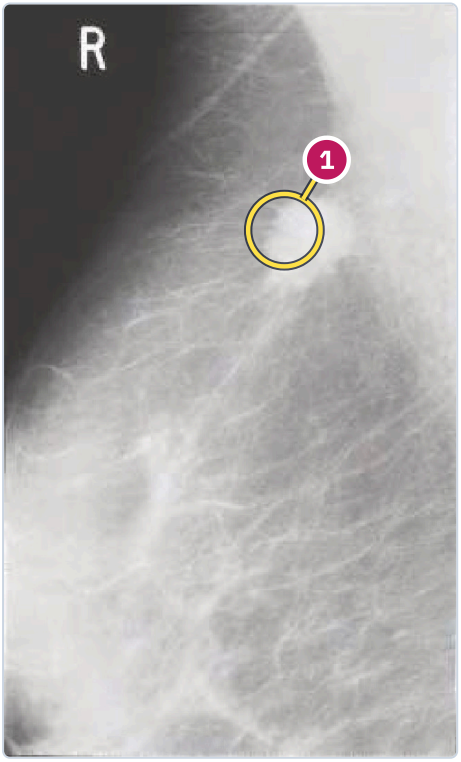


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 53.2

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa

DIAGNÓSTICO

Masa espiculada

Nódulo de bordes espiculados.

CONDUCTA INICIAL

BI-RADS 5: biopsia.

3.01.4.002 Mamografía — examen/procedimiento

4.01.1.035 Cáncer de mama — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Quiste: liso.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P166 «Una paciente de 47 años acude a control ginecológico, observándose salida de secreción escasa por el pezón a la compresión, que ella no había…» → **Realizar control mamográfico en un año**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 76** Tema 20.14

Clase 20.14 en video

41 TEMA 20.14 · CÁNCER DE MAMA GES, TAMIZAJE MAMOGRÁFICO (BI-RADS) Y PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA

IMAGEN RADIOLÓGICA

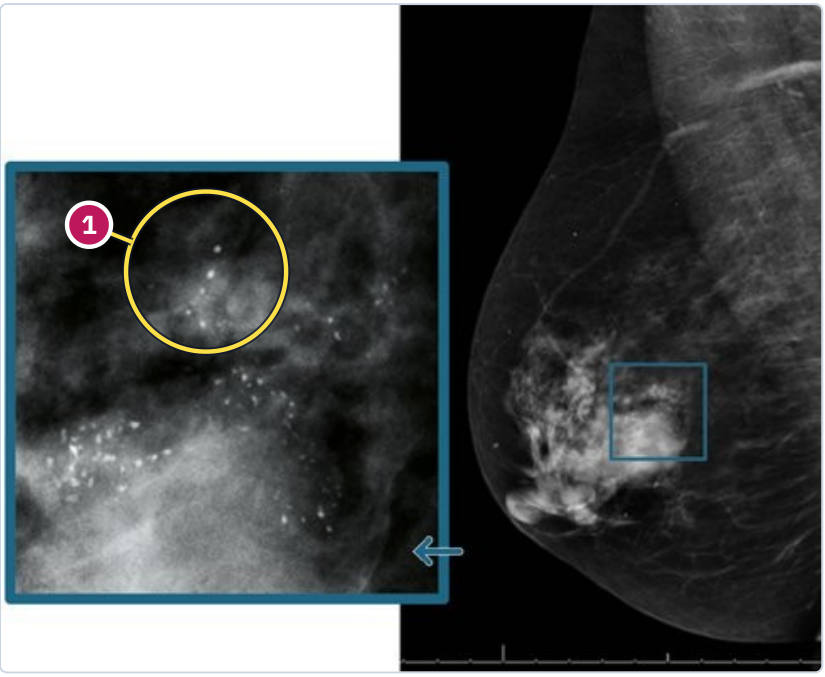


Imagen: Manual AMIR Ginecología y Obstetricia, p. 135

QUÉ TIENES QUE VER

1 Microcalcificaciones

DIAGNÓSTICO

Microcalcificaciones agrupadas

Magnificación de calcificaciones finas.

CONDUCTA INICIAL

Agrupadas y pleomorfas: biopsia estereotáxica.

4.01.3.012	Diagnóstico precoz del cáncer mamario — examen/procedimiento
3.01.4.002	Mamografía — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Calcificaciones benignas gruesas.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P156 «Mujer con microcalcificaciones agrupadas en mamografía (no palpables, no visibles en ECO), BIRADS-4. ¿Cuál es la conducta más adecuada?» → **Biopsia estereotáxica**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 76
Tema 20.14

Clase 20.14 en video

42 TEMA 20.14 · CÁNCER DE MAMA GES, TAMIZAJE MAMOGRÁFICO (BI-RADS) Y PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA

FOTO CLÍNICA

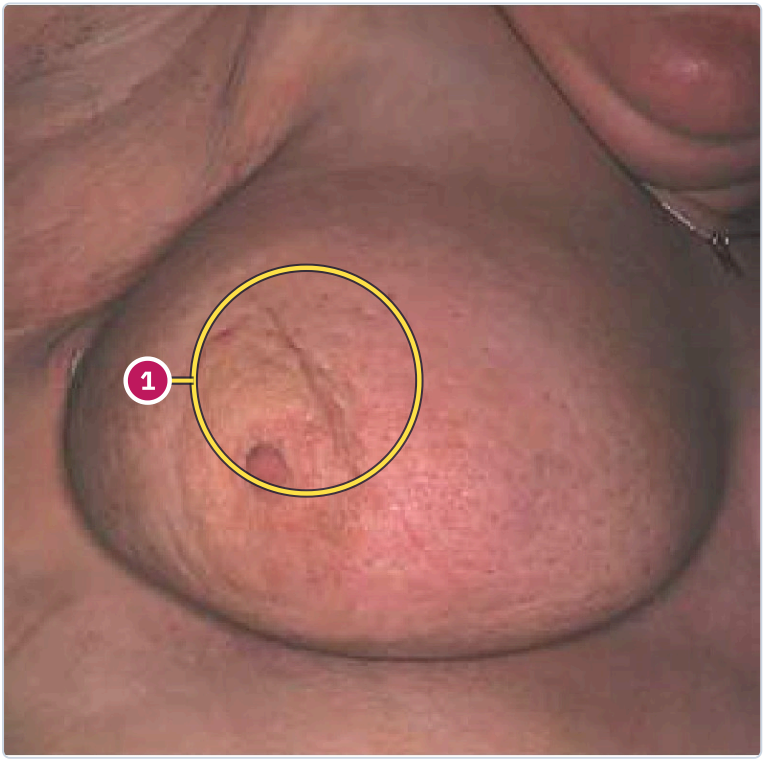


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 53.24

QUÉ TIENES QUE VER

1 Piel de naranja

DIAGNÓSTICO

Piel de naranja

Edema cutáneo con poros marcados.

CONDUCTA INICIAL

Cáncer inflamatorio: biopsia.

3.01.1.030	Cáncer de mama	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.035	Cáncer de mama	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mastitis.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P27 «Una paciente de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indolora, de consistencia dura y adherida a planos…» → **Cáncer de mama**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 76
Tema 20.14

Clase 20.14 en video

43 TEMA 20.14 · CÁNCER DE MAMA GES, TAMIZAJE MAMOGRÁFICO (BI-RADS) Y PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA

ECOGRAFÍA

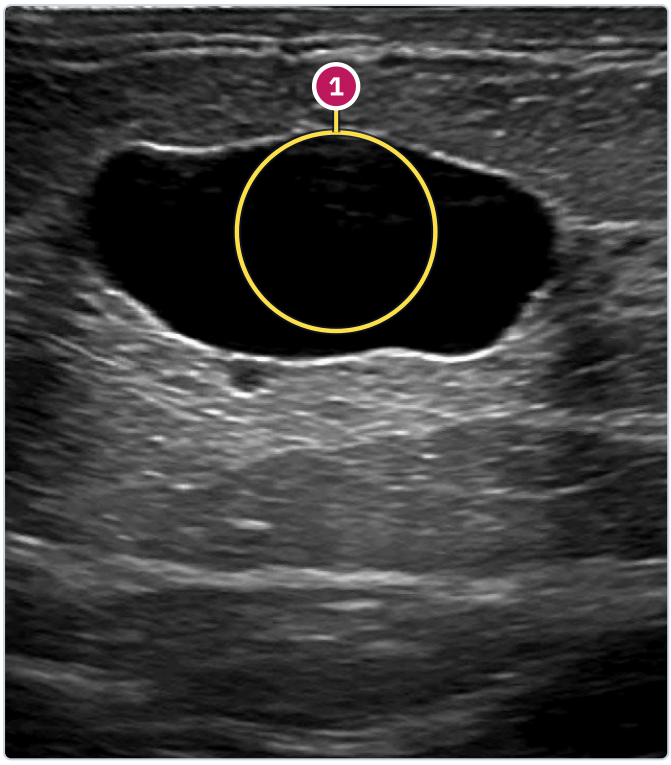


Imagen: Diagnostic Ultrasound (Rumack), Fig. 20-40

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quiste

DIAGNÓSTICO

Quiste simple de mama

Anecoico, pared fina y refuerzo posterior.

CONDUCTA INICIAL

BI-RADS 2: control habitual.

3.01.1.029 **Patología benigna de mama**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

3.01.4.006 **Ecotomografía mamaria**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Fibroadenoma: sólido.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P161** «Una paciente de 24 años se autopalpa un nódulo mamario de 2 cm, indolora, que no está adherida a la piel ni a planos profundos. Se solicita una…» → **Fibroadenoma**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 78** Tema 20.14

Clase 20.14 en video

44 TEMA 20.15 · CÁNCER DE ENDOMETRIO Y MASA ANEXIAL / CÁNCER DE OVARIO

ECOGRAFÍA

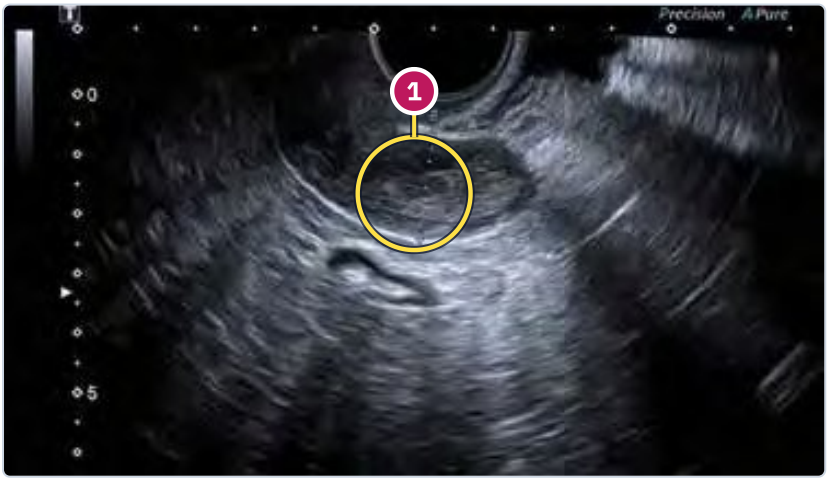


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 69

QUÉ TIENES QUE VER

1 Endometrio

DIAGNÓSTICO

Endometrio engrosado

Posmenopáusica con endometrio > 4 mm.

CONDUCTA INICIAL

Metrorragia posmenopáusica: biopsia.

3.01.1.024 **Patología maligna del endometrio**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Atrofia.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P178** «Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta…» → **Solicitar ecografía transvaginal**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 81** Tema 20.15

Clase 20.15 en video

45 TEMA 20.15 · CÁNCER DE ENDOMETRIO Y MASA ANEXIAL / CÁNCER DE OVARIO

ENDOSCOPÍA

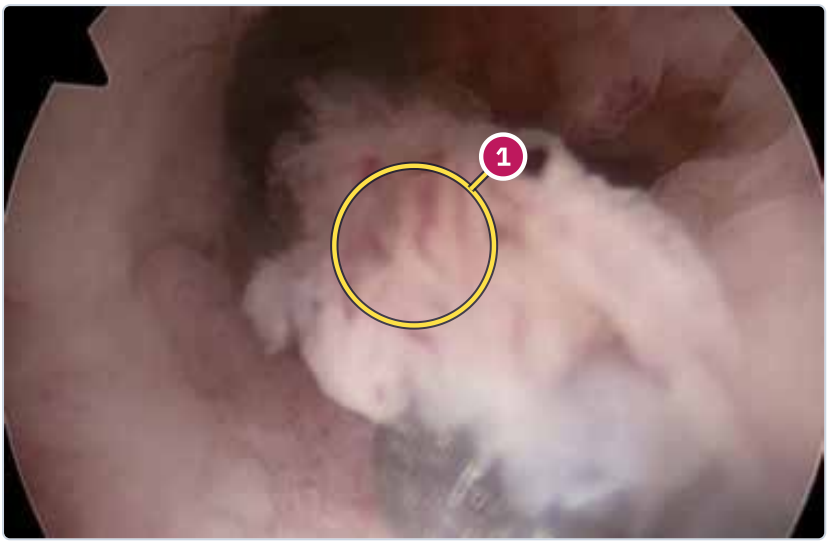


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 69

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tumor

DIAGNÓSTICO

Cáncer de endometrio en la histeroscopía

Masa irregular.

CONDUCTA INICIAL

Histerectomía con etapificación.

3.01.1.024 **Patología maligna del endometrio**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 81** Tema 20.15

Clase 20.15 en video

46 TEMA 20.15 · CÁNCER DE ENDOMETRIO Y MASA ANEXIAL / CÁNCER DE OVARIO

IMAGEN RADIOLÓGICA

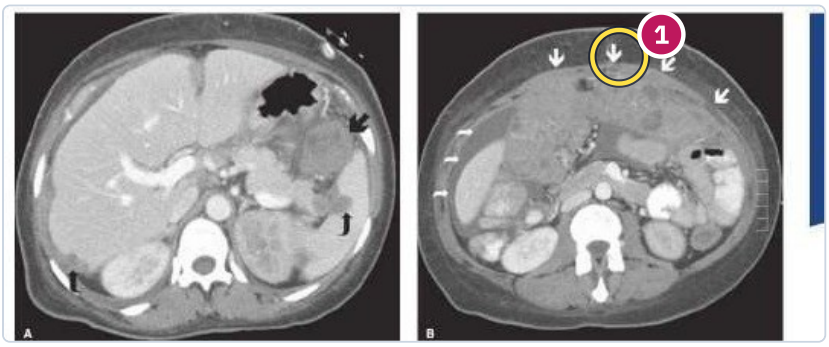


Imagen: Williams Gynecology, 4.ª ed., p. 741

QUÉ TIENES QUE VER

1 Omento

DIAGNÓSTICO

Cáncer de ovario avanzado

Ascitis y carcinomatosis omental (flechas).

CONDUCTA INICIAL

CA-125 y cirugía citorreductora.

3.01.1.028 **Tumores ováricos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.08.3.002 **Conceptos generales de etapificación, radioterapia y quimioterapia**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Ascitis cirrótica.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P87** «Una paciente de 70 años consulta por dolor abdominal, de intensidad progresiva, que inició hace 4 meses. Ha bajado 5 kilogramos de peso. Al…» → **Cáncer de ovario**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA **p. 81** Tema 20.15

Clase 20.15 en video

47 TEMA 20.16 · URGENCIAS GINECOLÓGICAS QUIRÚRGICAS

ECOGRAFÍA

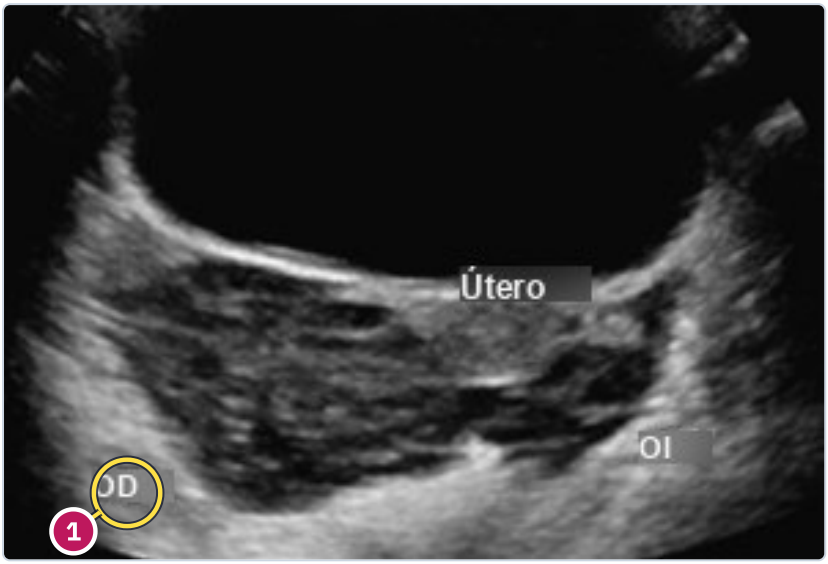


Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 590.4

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ovario

DIAGNÓSTICO

Ovario aumentado en la torsión

Ovario derecho (OD) aumentado.

CONDUCTA INICIAL

Torsión: cirugía urgente.

3.01.2.019 Quiste ovárico torcido

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Quiste funcional.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P58 «Una paciente de 30 años consulta por dolor en la fosa iliaca derecha, que se ha asociado a vómitos alimentarios y que inició hace 48 horas. Al…» → **Tumor anexial torcido**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 86
Tema 20.16

Clase 20.16 en video

48 TEMA 20.16 · URGENCIAS GINECOLÓGICAS QUIRÚRGICAS

ECOGRAFÍA

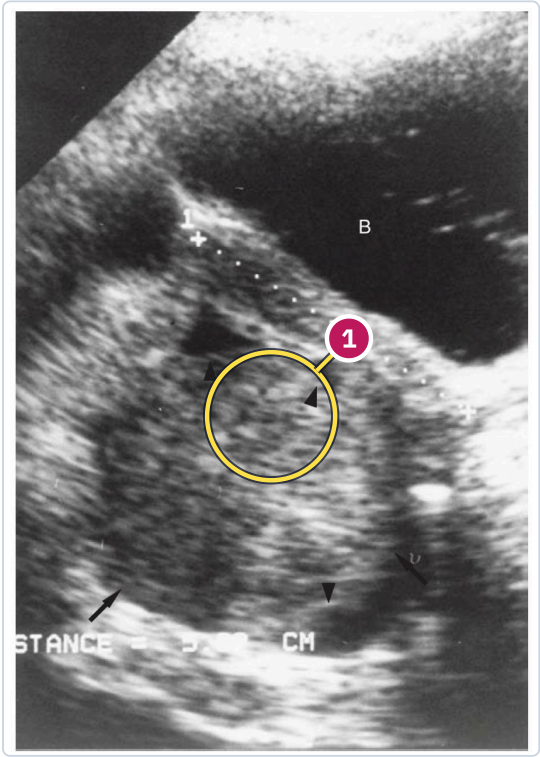


Imagen: Pocket Atlas of Emergency Ultrasound (Reardon, Ma), p. 282

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pedículo

DIAGNÓSTICO

Signo del remolino

Pedículo vascular torcido.

CONDUCTA INICIAL

Laparoscopía y destorsión.

3.01.2.019 Quiste ovárico torcido

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Vaso normal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 86
Tema 20.16

Clase 20.16 en video

49 TEMA 20.16 · URGENCIAS GINECOLÓGICAS QUIRÚRGICAS

ECOGRAFÍA

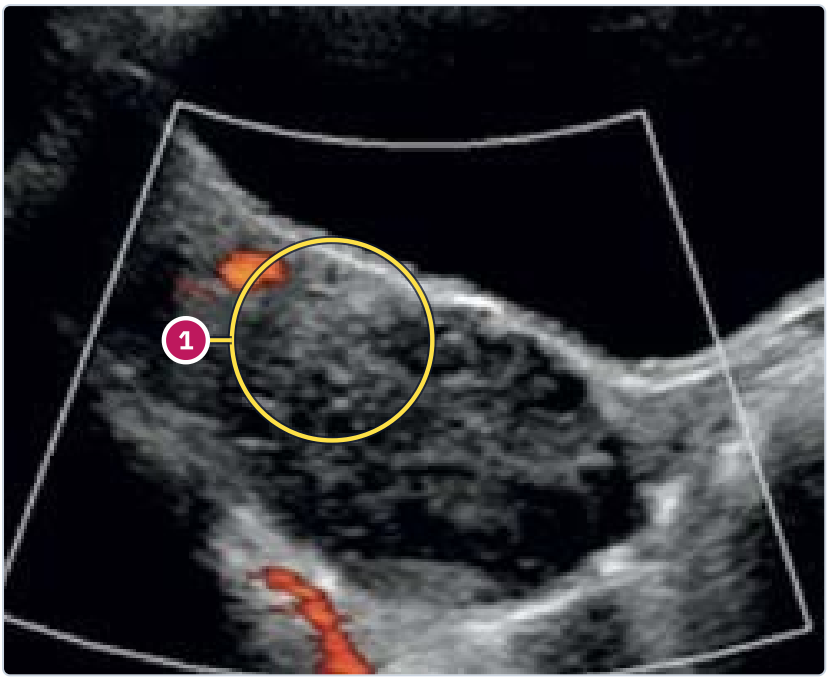


Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 590.4

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ovario

DIAGNÓSTICO

Doppler en la torsión

Flujo escaso en el ovario.

CONDUCTA INICIAL

Doppler normal no descarta torsión.

3.01.2.019 Quiste ovárico torcido

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Ovario normal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 86
Tema 20.16

Clase 20.16
en video

50 TEMA 20.16 · URGENCIAS GINECOLÓGICAS QUIRÚRGICAS

ECOGRAFÍA

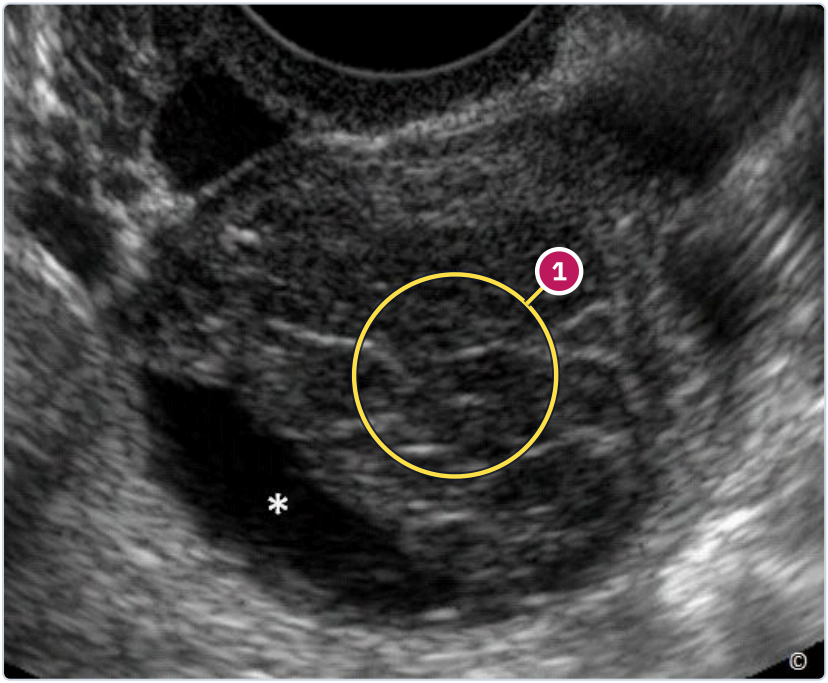


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 260

QUÉ TIENES QUE VER

1 Patrón en red

DIAGNÓSTICO

Quiste hemorrágico del cuerpo lúteo

Patrón en red (*).

CONDUCTA INICIAL

Estable: manejo expectante.

3.01.2.016 Dolor pélvico agudo

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Endometrioma.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P169 «Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor ab- dominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su FUR fue…» → **Cuerpo lúteo hemorrágico**

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 86
Tema 20.16

Clase 20.16
en video

51 TEMA 20.16 · URGENCIAS GINECOLÓGICAS QUIRÚRGICAS

ECOGRAFÍA

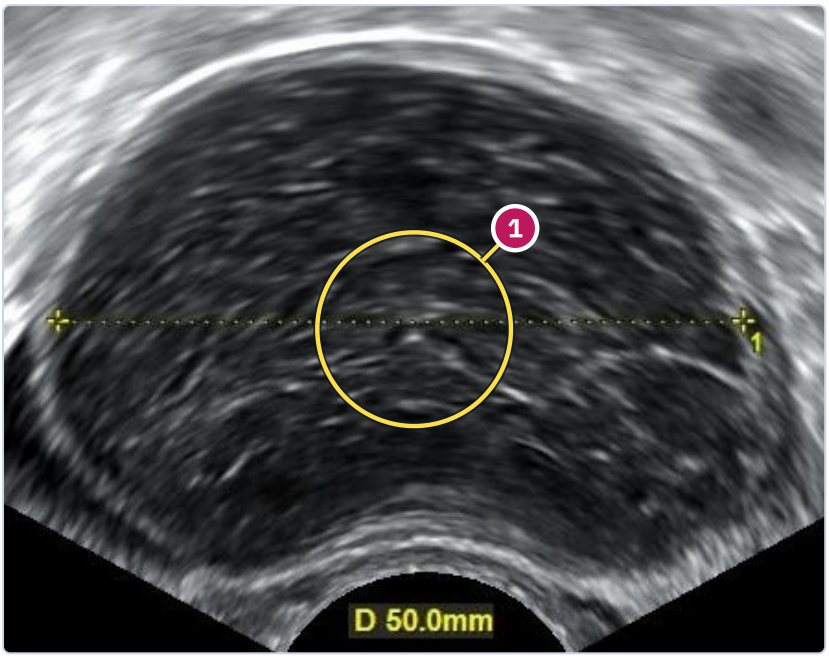


Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Quiste

DIAGNÓSTICO

Quiste hemorrágico de 5 cm

Ecos finos en red.

CONDUCTA INICIAL

Control ecográfico en 6–8 semanas.

3.01.2.016 Dolor pélvico agudo

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tumor sólido.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
p. 86
Tema 20.16

Clase 20.16 en video

Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Quiste vs absceso de Bartolino



VS



A **Quiste de Bartolino**

- Indoloro

Ficha n.° 29 · p. 18

B **Absceso de Bartolino**

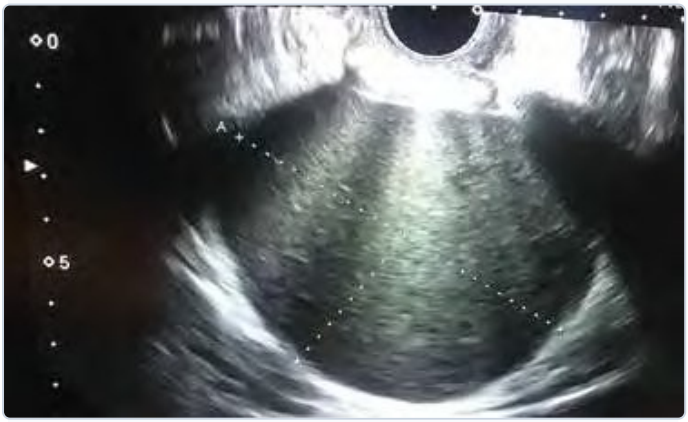
- Doloroso, rojo

Ficha n.° 30 · p. 18

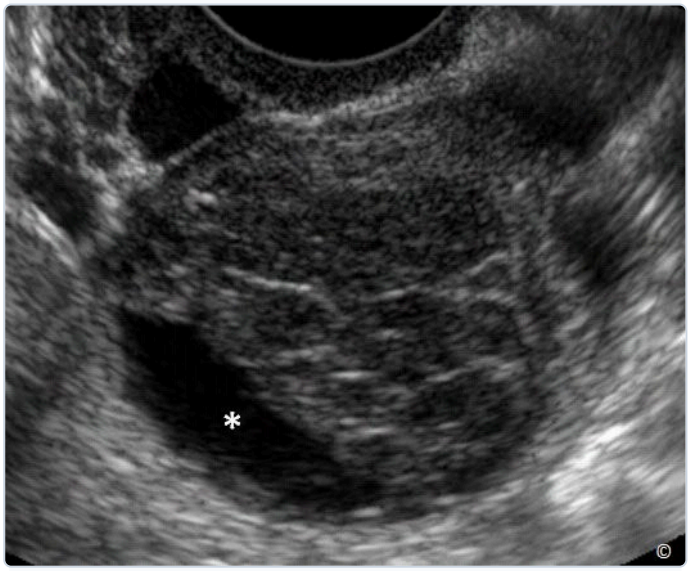
LA DIFERENCIA El absceso se drena.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Endometrioma vs quiste hemorrágico



VS



A **Endometrioma**

- Vidrio esmerilado

Ficha n.° 14 · p. 10

B **Quiste hemorrágico del cuerpo lúteo**

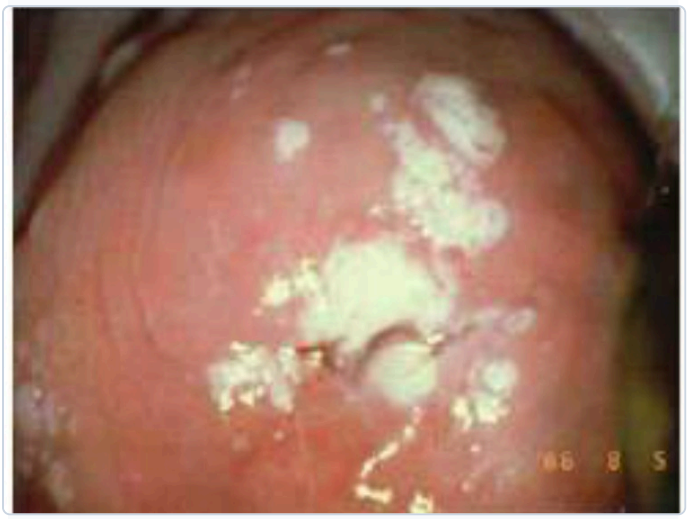
- Patrón en red

Ficha n.° 50 · p. 28

LA DIFERENCIA El hemorrágico se resuelve solo.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Bajo vs alto grado



VS



A Lesión de bajo grado en la colposcopía

- Acetoblanco fino

Ficha n.° 36 · p. 21

B Lesión de alto grado

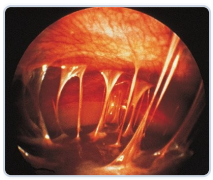
- Acetoblanco denso

Ficha n.° 37 · p. 22

LA DIFERENCIA Alto grado: conización.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



CUERDAS DE VIOLÍN

Adherencias perihepáticas.

Se ve en: Fitz-Hugh-Curtis.

Tomo p. 57 · Atlas: ficha n.° 35, p. 21

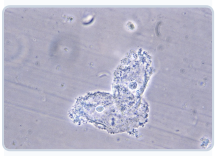


SIGNO DEL REMOLINO

Pedículo vascular torcido.

Se ve en: Torsión anexial.

Tomo p. 86 · Atlas: ficha n.° 48, p. 27



CÉLULAS CLAVE

Células epiteliales cubiertas de bacterias.

Se ve en: Vaginosis bacteriana.

Tomo p. 48 · Atlas: ficha n.° 27, p. 17



PIEL DE NARANJA

Edema cutáneo con poros marcados.

Se ve en: Cáncer de mama inflamatorio.

Tomo p. 76 · Atlas: ficha n.° 42, p. 24

Índice por tipo de imagen

19	2	6	7	16	1
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	ECOGRAFÍA	ENDOSCOPÍA

Foto clínica · 19

02 Síndrome de Turner (20.1) 4
04 Acantosis nigricans (20.2) 5
09 Cáncer cervicouterino (20.3) 8
11 Mioma intramural en laparoscopía (20.4) 9
16 Implantes de endometriosis en laparoscopía (20.5) 11
19 Procidencia genital (20.6) 13
23 Implante subdérmico (20.8) 15
24 Retiro del implante (20.8) 15
25 DIU de cobre y de levonorgestrel (20.8) 16
26 Vaginosis bacteriana (20.9) 16
28 Leucorrea candidiásica (20.9) 17
29 Quiste de Bartolino (20.10) 18
30 Absceso de Bartolino (20.10) 18
31 Liquen escleroso (20.10) 19
33 Absceso tuboovárico: visión quirúrgica (20.11) 20
35 Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (20.11) 21
36 Lesión de bajo grado en la colposcopía (20.13) 21
37 Lesión de alto grado (20.13) 22
42 Piel de naranja (20.14) 24

Histología / citología · 2

27 Células clave (20.9) 17
39 Citología: lesión de alto grado (20.13) 23

Esquema · 6

01 Ciclo menstrual de 28 días (20.1) 4
06 Escala de Ferriman-Gallwey (20.2) 6
07 Clasificación PALM-COEIN (20.3) 7
10 Clasificación FIGO de los miomas (20.4) 8
18 Sistema POP-Q (20.6) 12
38 Toma de Papanicolau (20.13) 22

Imagen radiológica · 7

03 Macroprolactinoma en la RM (20.1) 5
12 Mioma que comprime el recto (20.4) 9
20 Cavidad uterina en la HSG (20.7) 13
21 Histerosalpingografía normal (20.7) 14
40 Masa espiculada (20.14) 23
41 Microcalcificaciones agrupadas (20.14) 24
46 Cáncer de ovario avanzado (20.15) 26

Ecografía · 16

05 Ovario poliquístico (20.2) 6
08 Pólipos endometriales (20.3) 7
13 Mioma en la ecografía transvaginal (20.4) 10
14 Endometrioma (20.5) 10
15 Endometrioma con Doppler (20.5) 11
17 Adenomiosis (20.5) 12
22 Hidrosálpinx (20.7) 14
32 Absceso tuboovárico (20.11) 19
34 Absceso tuboovárico en el Douglas (20.11) 20
43 Quiste simple de mama (20.14) 25
44 Endometrio engrosado (20.15) 25
47 Ovario aumentado en la torsión (20.16) 27
48 Signo del remolino (20.16) 27
49 Doppler en la torsión (20.16) 28
50 Quiste hemorrágico del cuerpo lúteo (20.16) 28
51 Quiste hemorrágico de 5 cm (20.16) 29

Endoscopía · 1

45 Cáncer de endometrio en la histeroscopía (20.15) 26

Autoevaluación

6 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

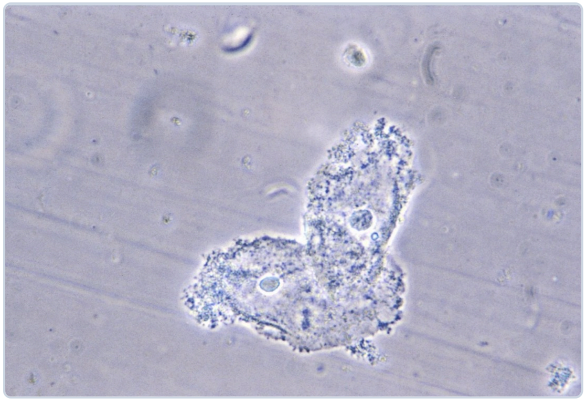
1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



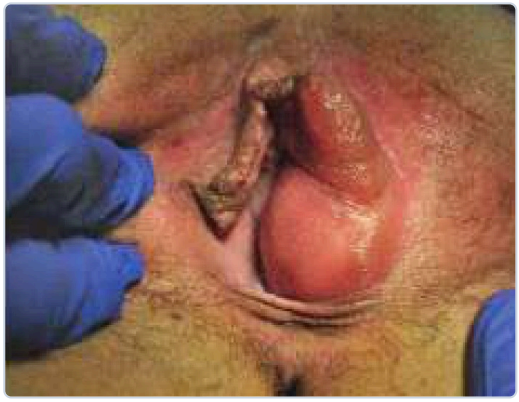
2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



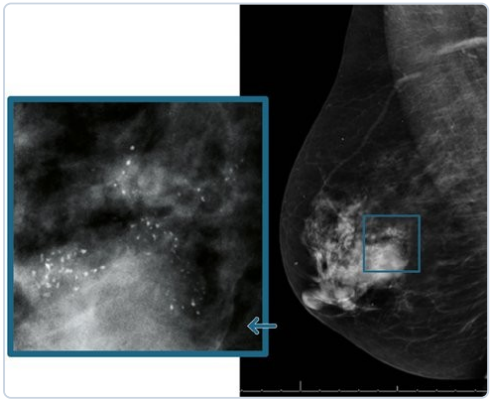
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



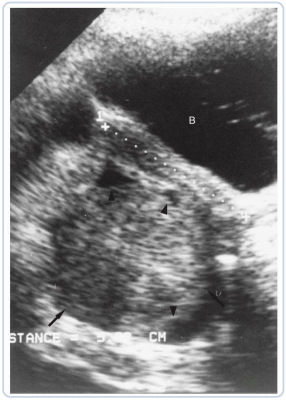
4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Ovario poliquístico**	Folículos periféricos	05 · p. 6
2	**Procidencia genital**	Prolapso total	19 · p. 13
3	**Células clave**	Célula clave	27 · p. 17
4	**Absceso de Bartolino**	Absceso	30 · p. 18
5	**Microcalcificaciones agrupadas**	Microcalcificaciones	41 · p. 24
6	**Signo del remolino**	Pedículo	48 · p. 27